ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

Libro Gordo

ENDOCRINOLOGÍA

90 preguntas de práctica

Metabolismo

MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Endocrinología · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
BLOQUE 1: PATOLOGÍA TIROIDEA FUNCIONAL: HIPOTIROIDISMO Y TIROIDITIS					
1.03.1.002	Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q1	Tomo 07 · C.2 (Pág. 8)
1.03.1.005	Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q2	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.1.011	Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q3	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.1.017	Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q4	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.2.002	Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q11	Tomo 07 · C.4 (Pág. 12)
1.03.2.004	Tiroiditis: Hashimoto, De Quervain (Subaguda), Silente y Fármacos (Amiodarona, Litio)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q18	Tomo 07 · C.6 (Pág. 16)
1.05.1.005	Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q16, Q17	Tomo 07 · 1.1 (Pág. 5)
1.05.2.003	Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q12, Q13, Q14, Q15	Tomo 07 · 1.3 (Pág. 11)
4.01.1.013	Hipotiroidismo en Situaciones Especiales: Embarazo y Tamizaje Neonatal Congénito	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q16, Q17	Tomo 07 · 1.4 (Pág. 15)
BLOQUE 2: BLOQUE 2 · TIROTOXICOSIS, BOCIO, NÓDULO Y CÁNCER DE TIROIDES					
1.03.1.001	Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q20	Tomo 07 · C.1 (Pág. 6)
1.03.1.003	Hipertiroidismo	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q19	Tomo 17 · 17.6 (Pág. 24)
1.03.1.004	Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q21	Tomo 07 · C.52 (Pág. 108)
1.03.1.021	Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q33	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.2.001	Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q28	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.04.1.002	Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos	Dx: **TSH suprimida (< 0.01 mIU/L), T4L/T3 elevadas, TRAb positivos (> 1.75 UI/L) y ecografía doppler con infierno tiroideo**	GES	Q22, Q23, Q24, Q25, Q26, Q27, Q29, Q30, Q31, Q32	Tomo 06 · 1.2 (Pág. 7)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
		Tx: **Tiamazol 10-30 mg/día (o PTU en 1er trimestre), betabloqueo sintomático (propranolol/atenolol), radioyodo I-131 o tiroidectomía** · Seg: **Control T4L/T3 a las 4-6 semanas (la TSH puede permanecer suprimida meses). Monitoreo estricto de neutrófilos si fiebre o dolor faríngeo**			
1.04.1.003	Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF	Dx: **TSH sérica + Ecografía tiroidea de alta resolución estandarizada con sistema ACR TI-RADS o ATA** Tx: **Según resultado citológico Bethesda: Bethesda II (seguimiento ecográfico), Bethesda V/VI (cirugía oncológica), nódulos calientes (I-131/Cx)** · Seg: **Control ecográfico a los 6-12 meses según categoría de riesgo ecográfico y estabilidad dimensional**	GES	Q34, Q35, Q36	Tomo 02 · 4.6 (Pág. 50)
BLOQUE 3: BLOQUE 3 · CORTEZA Y MÉDULA SUPRARRENAL: CUSHING, ADDISON, CONN Y FEOCROMOCITOMA					
1.03.1.006	Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q38	Tomo 07 · C.8 (Pág. 20)
1.03.1.007	Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q44	Tomo 07 · C.9 (Pág. 22)
1.03.1.008	Hirsutismo	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q37	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.1.019	Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q45	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.1.022	Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q39	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.2.003	Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q46	Tomo 07 · C.5 (Pág. 14)
1.04.1.005	Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico	Dx: **Demostrar hipercortisolismo con 2 pruebas de 1ra línea alteradas (CLU 24h, Nugent 1 mg, Cortisol salival nocturno) + ACTH plasmática** Tx: **Según etiología: Resección transesfenoidal (Enfermedad de Cushing), Suprarrenalectomía laparoscópica (Adenoma), ketoconazol/metirapona**	GES	Q40, Q41, Q42, Q43	Tomo 06 · 3.2 (Pág. 39)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
		· Seg: **Monitoreo de cortisol post-quirúrgico y reemplazo temporal con hidrocortisona por insuficiencia suprarrenal secundaria a atrofia del eje**			
1.04.1.006	Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria	Dx: **Cortisol plasmático matinal (< 3 mcg/dL confirma; 3-15 requiere test de ACTH/Synacthen). ACTH elevada confirma primaria (Addison); ACTH baja orienta a secundaria** Tx: **Reemplazo con Hidrocortisona (15-25 mg/día en 2-3 tomas) + Fludrocortisona (0.05-0.1 mg/día SOLO en primaria/Addison). Educar ajuste por estrés** · Seg: **Monitoreo clínico (peso, PA de pie/sentado, energía), electrolitos plasmáticos y renina plasmática. NUNCA guiar dosis con cortisol plasmático**	GES	Q47, Q48, Q49, Q50, Q51, Q52	Tomo 02 · 5.1 (Pág. 55)
1.04.1.007	Hiperaldosteronismo Primario (Síndrome de Conn) e HTA Secundaria	Dx: **Relación Aldosterona / Renina Plasmática (RAR > 20-30 con Aldosterona > 15 ng/dL) + Test confirmatorio (sobrecarga salina) + TC Suprarrenal** Tx: **Adenoma unilateral (Conn): Suprarrenalectomía laparoscópica unilateral curativa. Hiperplasia bilateral: Antagonistas del receptor mineralocorticoide (Espironolactona)** · Seg: **Monitorización de presión arterial, kalemia y función renal. Monitoreo de ginecomastia con espironolactona (rotar a Eplerenona si efectos adversos)**	GES	Q53, Q54	Tomo 02 · 2.4 (Pág. 22)
BLOQUE 4: BLOQUE 4 · METABOLISMO MINERAL, CALCIO, PARATIROIDES Y HUESO					
1.03.1.018	Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q68	Tomo 07 · C.34 (Pág. 72)
1.03.1.020	Hipercalcemias e hipocalcemias	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q55, Q56, Q57, Q58, Q59, Q60	Tomo 07 · C.21 (Pág. 46)
1.03.2.005	Tetania	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q61	Tomo 07 · C.7 (Pág. 18)
1.04.1.009	Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico	Dx: **Calcio total corregido por albúmina o Calcio Iónico + PTH intacta (PTHi). PTH**	GES	Q62, Q63, Q64, Q65	Tomo 06 · 3.1 (Pág. 37)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
		elevada/inapropiada = HPT 1°; PTH suprimida = Neoplasia / Vit D Tx: **Crisis aguda: Suero fisiológico 0.9% enérgico + Ácido Zoledrónico EV +/- Calcitonina. HPT 1°: Paratiroidectomía si cumple criterios** · Seg: **Calcio sérico, fósforo y función renal post-resección. Monitoreo de hipocalcemia severa por 'Síndrome del Hueso Hambriento'**			
1.04.1.010	Hipocalcemia Aguda y Crónica: Diagnóstico y Manejo de Emergencia	Dx: **Calcio total corregido por albúmina < 8.5 mg/dL o Calcio Iónico < 4.0 mg/dL (1.0 mmol/L) + Signos de irritabilidad neuromuscular (Trousseau / Chvostek)** Tx: **Aguda sintomática: Gluconato de Calcio al 10% 1-2 ampollas EV en 10-20 min + infusión continua. Corregir magnesio si hipomagnesemia** · Seg: **Monitoreo cardíaco continuo (riesgo QT largo y arritmias). Monitoreo de calcemia, magnesemia y producto calcio-fósforo en tratamiento crónico**	GES	Q66, Q67	Tomo 02 · 3.5 (Pág. 35)
1.04.1.011	Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento	Dx: **Densitometría ósea DEXA: T-score ≤ -2.5 en columna lumbar, cuello femoral o cadera total, O presencia de fractura por fragilidad** Tx: **1ra Línea: Alendronato 70 mg/semana VO (o Ácido Zoledrónico 5 mg/año EV) + Calcio (1000-1200 mg/d) + Vitamina D3 (800-2000 UI/d)** · Seg: **DEXA de control cada 1-2 años. Evaluar 'vacaciones terapéuticas' con bifosfonatos a los 3-5 años por riesgo de fractura atípica de fémur y osteonecrosis mandibular**	GES	Q69, Q70	Tomo 02 · 5.3 (Pág. 59)
1.04.1.012	Déficit de Vitamina D, Osteomalacia del Adulto y Raquitismo	Dx: **25-hidroxivitamina D sérica [25(OH)D]: < 20 ng/mL = Deficiencia; 20-29 ng/mL = Insuficiencia; ≥ 30 ng/mL = Suficiencia óptima** Tx: **Deficiencia (< 20 ng/mL): Colecalciferol (D3) 50.000 UI semanal por 8 semanas (o 6.000 UI/día), seguido de**	GES	Q71, Q72	Tomo 02 · 4.5 (Pág. 48)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
		mantención 1.000-2.000 UI/día · Seg: **Control de 25(OH)D sérica a los 3-4 meses de iniciada la carga de reposición. Monitoreo de calcemia y fosfemia**			
BLOQUE 5: BLOQUE 5 · HIPÓFISIS, HIPOTÁLAMO, NEUROENDOCRINOLOGÍA Y MEN					
1.03.1.009	Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q76	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.1.010	Amenorrea	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q73	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.1.012	Hipogonadismo masculino	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q74	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.1.013	Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q77	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.1.014	Hipopituitarismo, Síndrome de Sheehan y Panhipopituitarismo	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q85	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.1.015	Diabetes Insípida, SIADH y Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q88	Tomo 07 · C.17 (Pág. 38)
1.03.1.016	Hiperprolactinemia y Prolactinomas: Diagnóstico y Terapia Médica	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q80	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.1.023	Ginecomastia	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q75	Tomo 07 · 7.25 (Pág. 81)
1.04.1.013	Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria	Dx: **RM de Silla Turca con gadolinio + Campo visual computarizado + Evaluación hormonal completa de todos los ejes hipofisarios** Tx: **Compresión quiasmática o tumores no funcionantes grandes: Cirugía transesfenoidal. Apoplejía: Hidrocortisona EV inmediata +/- descompresión urgente** · Seg: **RM de control anual, campimetría periódica y seguimiento hormonal para pesquisar hipopituitarismo diferido postquirúrgico**	GES	Q78, Q79	Tomo 02 · 4.4 (Pág. 46)
1.04.1.014	Hiperprolactinemia y Prolactinomas: Diagnóstico y Terapia Médica	Dx: **Prolactina sérica basal > 25 ng/mL (en ayuno, sin estrés, reposo 30 min). > 100 ng/mL = Prolactinoma altamente probable; > 200 ng/mL = casi patognomónico** Tx: **1ra Línea ABSOLUTA: Agonistas Dopaminérgicos (Cabergolina 0.5 mg 1-2 veces/semana VO).**	GES	Q81, Q82	Tomo 02 · 3.1 (Pág. 27)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
		Cirugía transesfenoidal solo si resistencia/intolerancia · Seg: **Prolactina sérica a los 3 meses y RM de silla turca de control al año para evaluar reducción tumoral. Monitoreo de ecocardiograma si dosis altas**			
1.04.1.015	Acromegalia y Gigantismo: Diagnóstico Bioquímico y Manejo	Dx: **Tamizaje: IGF-1 sérica elevada para edad y sexo. Confirmación: Test de Sobrecarga Oral de Glucosa (PTGO 75g con GH que no suprime a < 1.0 o 0.4 mcg/L)** Tx: **1ra Línea: Cirugía de Resección Transesfenoidal del adenoma somatotropo. Terapia médica coadyuvante: Análogos de Somatostatina (Octreótido/Lanreótido)** · Seg: **Monitoreo anual con IGF-1 y GH post-PTGO. Colonoscopía periódica (riesgo elevado de pólipos premalignos y cáncer colorrectal) y ecocardiograma**	GES	Q83, Q84	Tomo 02 · 2.3 (Pág. 20)
1.04.1.016	Hipopituitarismo, Síndrome de Sheehan y Panhipopituitarismo	Dx: **Hormonas diana disminuidas (Cortisol, T4L, Estradiol/Testosterona) con tropinas hipofisarias bajas o 'inapropiadamente normales' (ACTH, TSH, LH/FSH)** Tx: **Reemplazo hormonal escalonado. REGLA DE ORO DE SEGURIDAD: Iniciar SIEMPRE Glucocorticoides (Hidrocortisona) ANTES que Levotiroxina** · Seg: **Monitoreo clínico, densitometría ósea y ajuste periódico de dosis según bienestar, peso y presión arterial. NUNCA guiar levotiroxina con TSH**	GES	Q86, Q87	Tomo 02 · 5.6 (Pág. 65)
1.04.1.017	Diabetes Insípida, SIADH y Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN)	Dx: **Poliuria hipotónica: Osm urinaria < 300 mOsm/kg + Test de deprivación hídrica (Miller) y Desmopresina. Hiponatremia euvolémica: SIADH (Osm orina > 100)** Tx: **DI Central: Desmopresina (DDAVP) nasal u oral. DI Nefrogénica: Hidroclorotiazida + Amilorida. SIADH:**	GES	Q89, Q90	Tomo 02 · 4.5 (Pág. 48)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
		Restricción de fluidos (500-1000 mL/d) · Seg: **Monitoreo estricto de sodio plasmático para evitar Síndrome de Desmielinización Osmótica (corrección máxima < 8-10 mEq/L en 24h)**			

ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Endocrinología · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)

TOMO 07 · PARTE B: ORDEN NUMÉRICO

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.03.1.001	Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q20	Tomo 07 · C.1 (Pág. 6)
1.03.1.002	Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q1	Tomo 07 · C.2 (Pág. 8)
1.03.1.003	Hipertiroidismo	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q19	Tomo 17 · 17.6 (Pág. 24)
1.03.1.004	Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q21	Tomo 07 · C.52 (Pág. 108)
1.03.1.005	Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q2	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.1.006	Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q38	Tomo 07 · C.8 (Pág. 20)
1.03.1.007	Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q44	Tomo 07 · C.9 (Pág. 22)
1.03.1.008	Hirsutismo	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q37	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.1.009	Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q76	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.1.010	Amenorrea	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q73	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.1.011	Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q3	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.1.012	Hipogonadismo masculino	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q74	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.1.013	Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q77	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.1.014	Hipopituitarismo, Síndrome de Sheehan y Panhipopituitarismo	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q85	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.1.015	Diabetes Insípida, SIADH y Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q88	Tomo 07 · C.17 (Pág. 38)
1.03.1.016	Hiperprolactinemia y Prolactinomas: Diagnóstico y Terapia Médica	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q80	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.1.017	Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	—	Q4	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.03.1.018	Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q68	Tomo 07 · C.34 (Pág. 72)
1.03.1.019	Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q45	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.1.020	Hipercalcemias e hipocalcemias	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q55, Q56, Q57, Q58, Q59, Q60	Tomo 07 · C.21 (Pág. 46)
1.03.1.021	Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q33	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.1.022	Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q39	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.1.023	Ginecomastia	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q75	Tomo 07 · 7.25 (Pág. 81)
1.03.2.001	Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q28	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.2.002	Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q11	Tomo 07 · C.4 (Pág. 12)
1.03.2.003	Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q46	Tomo 07 · C.5 (Pág. 14)
1.03.2.004	Tiroiditis: Hashimoto, De Quervain (Subaguda), Silente y Fármacos (Amiodarona, Litio)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q18	Tomo 07 · C.6 (Pág. 16)
1.03.2.005	Tetania	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q61	Tomo 07 · C.7 (Pág. 18)
1.04.1.002	Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos	Dx: **TSH suprimida (< 0.01 mIU/L), T4L/T3 elevadas, TRAb positivos (> 1.75 UI/L) y ecografía doppler con infierno tiroideo** Tx: **Tiamazol 10-30 mg/día (o PTU en 1er trimestre), betabloqueo sintomático (propranolol/atenolol), radioyodo I-131 o tiroidectomía** · Seg: **Control T4L/T3 a las 4-6 semanas (la TSH puede permanecer suprimida meses). Monitoreo estricto de neutrófilos si fiebre o dolor faríngeo**	GES	Q22, Q23, Q24, Q25, Q26, Q27, Q29, Q30, Q31, Q32	Tomo 06 · 1.2 (Pág. 7)
1.04.1.003	Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF	Dx: **TSH sérica + Ecografía tiroidea de alta resolución estandarizada con sistema ACR TI-RADS o ATA** Tx: **Según resultado citológico Bethesda: Bethesda II (seguimiento ecográfico), Bethesda V/VI (cirugía oncológica), nódulos calientes (I-131/Cx)** · Seg: **Control ecográfico**	GES	Q34, Q35, Q36	Tomo 02 · 4.6 (Pág. 50)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
		a los 6-12 meses según categoría de riesgo ecográfico y estabilidad dimensional			
1.04.1.005	Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico	Dx: **Demostrar hipercortisolismo con 2 pruebas de 1ra línea alteradas (CLU 24h, Nugent 1 mg, Cortisol salival nocturno) + ACTH plasmática** Tx: **Según etiología: Resección transesfenoidal (Enfermedad de Cushing), Suprarrenalectomía laparoscópica (Adenoma), ketoconazol/metirapona** · Seg: **Monitoreo de cortisol post-quirúrgico y reemplazo temporal con hidrocortisona por insuficiencia suprarrenal secundaria a atrofia del eje**	GES	Q40, Q41, Q42, Q43	Tomo 06 · 3.2 (Pág. 39)
1.04.1.006	Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria	Dx: **Cortisol plasmático matinal (< 3 mcg/dL confirma; 3-15 requiere test de ACTH/Synacthen). ACTH elevada confirma primaria (Addison); ACTH baja orienta a secundaria** Tx: **Reemplazo con Hidrocortisona (15-25 mg/día en 2-3 tomas) + Fludrocortisona (0.05-0.1 mg/día SOLO en primaria/Addison). Educar ajuste por estrés** · Seg: **Monitoreo clínico (peso, PA de pie/sentado, energía), electrolitos plasmáticos y renina plasmática. NUNCA guiar dosis con cortisol plasmático**	GES	Q47, Q48, Q49, Q50, Q51, Q52	Tomo 02 · 5.1 (Pág. 55)
1.04.1.007	Hiperaldosteronismo Primario (Síndrome de Conn) e HTA Secundaria	Dx: **Relación Aldosterona / Renina Plasmática (RAR > 20-30 con Aldosterona > 15 ng/dL) + Test confirmatorio (sobrecarga salina) + TC Suprarrenal** Tx: **Adenoma unilateral (Conn): Suprarrenalectomía laparoscópica unilateral curativa. Hiperplasia bilateral: Antagonistas del receptor mineralocorticoide (Espironolactona)** · Seg: **Monitorización de presión arterial, kalemia y función renal. Monitoreo de ginecomastia con**	GES	Q53, Q54	Tomo 02 · 2.4 (Pág. 22)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
		espironolactona (rotar a Eplerenona si efectos adversos)			
1.04.1.009	Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico	Dx: **Calcio total corregido por albúmina o Calcio Iónico + PTH intacta (PTHi). PTH elevada/inapropiada = HPT 1°; PTH suprimida = Neoplasia / Vit D** Tx: **Crisis aguda: Suero fisiológico 0.9% enérgico + Ácido Zoledrónico EV +/- Calcitonina. HPT 1°: Paratiroidectomía si cumple criterios** · Seg: **Calcio sérico, fósforo y función renal post-resección. Monitoreo de hipocalcemia severa por 'Síndrome del Hueso Hambriento'**	GES	Q62, Q63, Q64, Q65	Tomo 06 · 3.1 (Pág. 37)
1.04.1.010	Hipocalcemia Aguda y Crónica: Diagnóstico y Manejo de Emergencia	Dx: **Calcio total corregido por albúmina < 8.5 mg/dL o Calcio Iónico < 4.0 mg/dL (1.0 mmol/L) + Signos de irritabilidad neuromuscular (Trousseau / Chvostek)** Tx: **Aguda sintomática: Gluconato de Calcio al 10% 1-2 ampollas EV en 10-20 min + infusión continua. Corregir magnesio si hipomagnesemia** · Seg: **Monitoreo cardíaco continuo (riesgo QT largo y arritmias). Monitoreo de calcemia, magnesemia y producto calcio-fósforo en tratamiento crónico**	GES	Q66, Q67	Tomo 02 · 3.5 (Pág. 35)
1.04.1.011	Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento	Dx: **Densitometría ósea DEXA: T-score ≤ -2.5 en columna lumbar, cuello femoral o cadera total, O presencia de fractura por fragilidad** Tx: **1ra Línea: Alendronato 70 mg/semana VO (o Ácido Zoledrónico 5 mg/año EV) + Calcio (1000-1200 mg/d) + Vitamina D3 (800-2000 UI/d)** · Seg: **DEXA de control cada 1-2 años. Evaluar 'vacaciones terapéuticas' con bifosfonatos a los 3-5 años por riesgo de fractura atípica de fémur y osteonecrosis mandibular**	GES	Q69, Q70	Tomo 02 · 5.3 (Pág. 59)
1.04.1.012	Déficit de Vitamina D, Osteomalacia del Adulto y Raquitismo	Dx: **25-hidroxivitamina D sérica [25(OH)D]: < 20 ng/mL = Deficiencia; 20-29 ng/mL =**	GES	Q71, Q72	Tomo 02 · 4.5 (Pág. 48)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
		Insuficiencia; ≥ 30 ng/mL = Suficiencia óptima Tx: **Deficiencia (< 20 ng/mL): Colecalciferol (D3) 50.000 UI semanal por 8 semanas (o 6.000 UI/día), seguido de mantención 1.000-2.000 UI/día** · Seg: **Control de 25(OH)D sérica a los 3-4 meses de iniciada la carga de reposición. Monitoreo de calcemia y fosfemia**			
1.04.1.013	Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria	Dx: **RM de Silla Turca con gadolinio + Campo visual computarizado + Evaluación hormonal completa de todos los ejes hipofisarios** Tx: **Compresión quiasmática o tumores no funcionantes grandes: Cirugía transesfenoidal. Apoplejía: Hidrocortisona EV inmediata +/- descompresión urgente** · Seg: **RM de control anual, campimetría periódica y seguimiento hormonal para pesquisar hipopituitarismo diferido postquirúrgico**	GES	Q78, Q79	Tomo 02 · 4.4 (Pág. 46)
1.04.1.014	Hiperprolactinemia y Prolactinomas: Diagnóstico y Terapia Médica	Dx: **Prolactina sérica basal > 25 ng/mL (en ayuno, sin estrés, reposo 30 min). > 100 ng/mL = Prolactinoma altamente probable; > 200 ng/mL = casi patognomónico** Tx: **1ra Línea ABSOLUTA: Agonistas Dopaminérgicos (Cabergolina 0.5 mg 1-2 veces/semana VO). Cirugía transesfenoidal solo si resistencia/intolerancia** · Seg: **Prolactina sérica a los 3 meses y RM de silla turca de control al año para evaluar reducción tumoral. Monitoreo de ecocardiograma si dosis altas**	GES	Q81, Q82	Tomo 02 · 3.1 (Pág. 27)
1.04.1.015	Acromegalia y Gigantismo: Diagnóstico Bioquímico y Manejo	Dx: **Tamizaje: IGF-1 sérica elevada para edad y sexo. Confirmación: Test de Sobrecarga Oral de Glucosa (PTGO 75g con GH que no suprime a < 1.0 o 0.4 mcg/L)** Tx: **1ra Línea: Cirugía de Resección Transesfenoidal del**	GES	Q83, Q84	Tomo 02 · 2.3 (Pág. 20)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
		adenoma somatotropo. Terapia médica coadyuvante: Análogos de Somatostatina (Octreótido/Lanreótido) · Seg: **Monitoreo anual con IGF-1 y GH post-PTGO. Colonoscopía periódica (riesgo elevado de pólipos premalignos y cáncer colorrectal) y ecocardiograma**			
1.04.1.016	Hipopituitarismo, Síndrome de Sheehan y Panhipopituitarismo	Dx: **Hormonas diana disminuidas (Cortisol, T4L, Estradiol/Testosterona) con tropinas hipofisarias bajas o 'inapropiadamente normales' (ACTH, TSH, LH/FSH)** Tx: **Reemplazo hormonal escalonado. REGLA DE ORO DE SEGURIDAD: Iniciar SIEMPRE Glucocorticoides (Hidrocortisona) ANTES que Levotiroxina** · Seg: **Monitoreo clínico, densitometría ósea y ajuste periódico de dosis según bienestar, peso y presión arterial. NUNCA guiar levotiroxina con TSH**	GES	Q86, Q87	Tomo 02 · 5.6 (Pág. 65)
1.04.1.017	Diabetes Insípida, SIADH y Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN)	Dx: **Poliuria hipotónica: Osm urinaria < 300 mOsm/kg + Test de deprivación hídrica (Miller) y Desmopresina. Hiponatremia euvolémica: SIADH (Osm orina > 100)** Tx: **DI Central: Desmopresina (DDAVP) nasal u oral. DI Nefrogénica: Hidroclorotiazida + Amilorida. SIADH: Restricción de fluidos (500-1000 mL/d)** · Seg: **Monitoreo estricto de sodio plasmático para evitar Síndrome de Desmielinización Osmótica (corrección máxima < 8-10 mEq/L en 24h)**	GES	Q89, Q90	Tomo 02 · 4.5 (Pág. 48)
1.05.1.005	Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q16, Q17	Tomo 07 · 1.1 (Pág. 5)
1.05.2.003	Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q12, Q13, Q14, Q15	Tomo 07 · 1.3 (Pág. 11)
4.01.1.013	Hipotiroidismo en Situaciones Especiales: Embarazo y Tamizaje Neonatal Congénito	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q16, Q17	Tomo 07 · 1.4 (Pág. 15)

SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

BLOQUE 1 PATOLOGÍA TIROIDEA FUNCIONAL: HIPOTIROIDISMO Y TIROIDITIS

PREGUNTA 1 1.03.1.002

1. Un paciente se realiza una tiroidectomía total hace varios años, por un carcinoma tiroideo. Suspende el tratamiento con levotiroxina hace 6 meses. ¿Qué alteración tendrá con mayor probabilidad en su examem físico?

A) Mixedema pretibial
B) Exoftalmo
C) Melanoplaquias
D) Piel seca
E) Acantosis nigricans

PREGUNTA 2 1.03.1.005

2. Una paciente de 23 años, consulta por malestar general y sensación febril de una semana de evolución, asociado a artralgias y palpitaciones. Al examen físico destaca glándula tiroides del doble del tamaño normal, muy dolorosa a la palpación, frecuencia cardiaca de 90 latidos por minuto y presión arterial de 120/80 mm Hg. Se solicitan exámenes que muestran TSH: 0,01 UI/L (valor normal: 0,3-4,5 UI/L), T4L: 1,9 ng/mL (valor normal: 0,6-1,7 ng/mL), captación de yodo radioactivo de 2% (valor normal: 20% a 30%). ¿Cuál es el tratamiento de elección en esta paciente?

A) Tiamazol
B) AINEs
C) Propiltiouracilo
D) Bloqueadores beta
E) Yodo radioactiivo en dosis terapéutica

PREGUNTA 3 1.03.1.011

3. [ATENCIÓN PRIMARIA: Síndrome climatérico · 1.03.1.011] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Síndrome climatérico. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 4 1.03.1.017

4. [ATENCIÓN PRIMARIA: Síndrome de secreción inapropiada de ADH · 1.03.1.017] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Síndrome de secreción inapropiada de ADH. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 5 1.05.1.005

5. Un paciente de 68 años se encuentra hospitalizado en la Unidad de Paciente Crítico recibiendo soporte hemodinámico y ventilatorio por una pancreatitis aguda necrohemorrágica grave con falla multiorgánica. En sus exámenes de laboratorio se documenta: TSH 0.8 mIU/L (normal 0.4–4.0), T4 libre 0.85 ng/dL (normal 0.8–1.9), T3 total 32 ng/dL (normal 80–200) y T3 reversa marcadamente elevada. ¿Cuál es la conducta terapéutica indicada respecto a este perfil hormonal?

A) Iniciar levotiroxina endovenosa en dosis sustitutiva completa
B) Iniciar triyodotironina (T3) oral por sonda nasoyeyunal
C) Mantener conducta expectante respecto al eje tiroideo y continuar el tratamiento intensivo de la pancreatitis
D) Iniciar hidrocortisona endovenosa en altas dosis para reactivar la secreción tiroidea
E) Solicitar tiroidectomía de urgencia para evitar tormenta tiroidea larvada

PREGUNTA 6 1.05.1.005

6. Una mujer de 54 años consulta por astenia leve y sequedad de piel. Sus exámenes de laboratorio revelan: TSH de 7.4 mIU/L (valor de referencia 0.4 a 4.0 mIU/L) y T4 Libre de 1.2 ng/dL (valor de referencia 0.8 a 1.8 ng/dL). ¿Cuál es la interpretación diagnóstica de este examen?

A) Hipotiroidismo primario clínico establecido
B) Hipotiroidismo subclínico
C) Hipotiroidismo central secundario
D) Resistencia a las hormonas tiroideas
E) Síndrome del eutiroideo enfermo

PREGUNTA 7 1.05.1.005

7. Un paciente de 60 años es diagnosticado de hipotiroidismo primario por tiroiditis de Hashimoto, con TSH de 38 mIU/L y T4 libre de 0.4 ng/dL. Como antecedentes refiere hipertensión arterial e infarto agudo de miocardio hace 3 años, actualmente asintomático. ¿Cuál es la dosis inicial de levotiroxina más recomendada para este paciente?

A) 150 mcg al día
B) 100 mcg al día
C) 1.6 mcg/kg de peso al día de inmediato
D) 25 a 50 mcg al día con titulación gradual según TSH
E) 12.5 mcg una vez a la semana en días alternos

PREGUNTA 8 1.05.1.005

8. Una mujer de 32 años, asintomática, que desea embarazarse en los próximos meses, se realiza exámenes de control de salud que muestran: TSH de 6.8 mIU/L y T4 libre de 1.1 ng/dL (rango normal 0.8 a 1.8 ng/dL). Sus anticuerpos anti-TPO resultan positivos en títulos elevados (480 UI/mL). ¿Cuál es la conducta más adecuada a seguir?

A) Tranquilizar a la paciente y citar a nuevo control de TSH en 1 año sin tratamiento
B) Iniciar tratamiento con levotiroxina a dosis bajas (25 a 50 mcg/día) con meta de TSH menor a 2.5 mIU/L
C) Iniciar tratamiento con propiltiouracilo para bloquear la autoinmunidad
D) Indicar dieta rica en yodo y suplementos de selenio sin fármacos
E) Solicitar una punción aspirativa con aguja fina de la glándula tiroides

PREGUNTA 9 1.05.1.005

9. ¿A las cuántas semanas de iniciado el tratamiento con levotiroxina o de un ajuste de dosis se debe solicitar el control de TSH plasmática para evaluar la eficacia y adecuar la dosificación?

A) A las 24 a 48 horas
B) A las 2 semanas
C) A las 6 a 8 semanas
D) A los 6 meses
E) Al año calendario

PREGUNTA 10 1.05.1.005

10. Un paciente de 52 años en tratamiento con levotiroxina 100 mcg al día por hipotiroidismo primario acude a control con TSH de 12.8 mIU/L. Refiere que toma rigurosamente su tableta todas las mañanas junto con el desayuno, acompañada de una taza de café con leche y una pastilla de carbonato de calcio con vitamina D y sulfato ferroso que le prescribieron para osteoporosis y anemia. ¿Cuál es la causa más probable de la falta de control bioquímico?

A) Desarrollo de anticuerpos bloqueadores del receptor de TSH
B) Interferencia y quelación en la absorción intestinal de levotiroxina por los alimentos, el café, el calcio y el hierro
C) Resistencia periférica severa a hormonas tiroideas de origen genético
D) Depuración renal acelerada de la hormona tiroidea por el calcio
E) Conversión periférica masiva de T4 a T3 tóxica

PREGUNTA 11 1.03.2.002

11. Una paciente de 46 años, con antecedentes de anemia perniciosa y vi`ligo, es traída al servicio de urgencia por un cuadro de malestar general y desorientación. Sus familiaees relatan que ha presentado compromiso del estado general y astenia de 3 semanas de evolución, asociando recientemente a somnolencia y desorientación. Al examen Fsico está en sopor superficial y sus signos vitales muestran presión arterial: 90/60 mmHg, frecuencia cardíaca: 62 lpm, temperatura: 36 °C. En el examen segmentario se obje8va lengua de gran tamaño y edema de extremidades inferiores. Al examen neurológico está soporosa, no 8ene focalidad neurológica y se observa enlentecimiento de la fase de relajación de los reflejos osteotendíneos. Los exámenes de laboratorio muestran sodio: 130 mEq/L, hemoglobina: 10 g/dl, hematocrito: 31%, VCM 102 fL, glóbulos blancos: 5.200/mm³ y plaquetas: 180.000/mm³. Se solicita TAC de cerebro, que no muestra alteraciones. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?

A) Suero hipertónico endovenoso
B) Suero fisiológico endovenoso
C) Levo2roxina endovenosa
D) Cor2coides endovenosos
E) An2bió2cos endovenosos

PREGUNTA 12 1.05.2.003

12. Una paciente de 76 años es llevada a la urgencia en estado de sopor profundo durante el invierno. Al examen físico destaca temperatura axilar de 32.5 °C, frecuencia cardíaca de 44 latidos por minuto, presión arterial de 82/50 mmHg y reflejos osteotendinosos abolidos. En sus exámenes destaca sodio plasmático de 121 mEq/L, glicemia de 62 mg/dL y una TSH de 88 mIU/L con T4 libre menor a 0.2 ng/dL. Además de intubación orotraqueal y soporte hemodinámico, ¿cuál es la medida farmacológica inmediata más importante?

A) Administrar 500 mcg de levotiroxina endovenosa en bolo exclusivo sin corticoides
B) Administrar hidrocortisona endovenosa en dosis de estrés antes o simultáneamente con la levotiroxina
C) Iniciar infusión de bicarbonato de sodio y realizar recalentamiento corporal activo en tina caliente
D) Administrar metimazol endovenoso para modular la respuesta autoinmune
E) Indicar hemodiálisis de urgencia para corregir la hiponatremia

PREGUNTA 13 1.05.2.003

13. ¿Cuál es el método de recalentamiento corporal indicado y seguro en un paciente cursando un coma mixedematoso con temperatura corporal central de 32 °C?

A) Inmersión inmediata del paciente en baño de agua caliente a 42 °C
B) Uso de lámparas infrarrojas y calentadores radiantes sobre la piel desnuda
C) Recalentamiento pasivo con mantas convencionales en un ambiente térmico templado
D) Infusión de suero fisiológico calentado a 50 °C por vía venosa central masiva
E) No se debe recalentar al paciente hasta que la TSH descienda a menos de 10 mIU/L

PREGUNTA 14 1.05.2.003

14. ¿Cuál de las siguientes alteraciones electrolíticas y metabólicas es característica y forma parte fundamental del síndrome de coma mixedematoso en adultos mayores?

A) Hipernatremia hiperosmolar severa
B) Hiponatremia hiposmolar dilucional asociada a hipoglicemia
C) Hipercalcemia maligna refractaria
D) Hipokalemia severa con alcalosis metabólica
E) Cetoacidosis con elevación del Anion Gap

PREGUNTA 15 1.05.2.003

15. Un paciente de 72 años con coma mixedematoso confirmado se encuentra intubado en la UCI recibiendo hidrocortisona EV y levotiroxina. Al monitor se observa PA 78/48 mmHg y bradicardia de 46 lpm refractaria a la administración de 2.000 ml de cristaloides. La ecocardiografía muestra derrame pericárdico moderado sin taponamiento y fracción de eyección de 35%. ¿A qué mecanismo fisiopatológico principal se atribuye la refractariedad del shock?

A) Vasoplejía séptica pura por toxina estreptocócica
B) Depresión miocárdica severa y cronotropismo negativo inducidos por déficit crítico de hormonas tiroideas a nivel celular
C) Tromboembolismo pulmonar masivo bilateral
D) Hiperaldosteronismo secundario con escape de sodio
E) Rotura de cuerda tendinosa mitral

PREGUNTA 16 1.05.1.005, 4.01.1.013

16. Una mujer de 29 años, con diagnóstico de hipotiroidismo primario en tratamiento estable con levotiroxina 75 mcg al día y TSH reciente de 1.8 mIU/L, acude a la consulta médica confirmando que tiene 5 semanas de amenorrea y un test de embarazo en orina positivo. ¿Cuál es la indicación médica inmediata más adecuada respecto a su terapia hormonal?

A) Suspender la levotiroxina durante el primer trimestre por riesgo teratogénico fetal
B) Mantener la dosis de 75 mcg/día sin cambios hasta el parto dado que la última TSH estaba normal
C) Incrementar de inmediato la dosis de levotiroxina en un 25 a 30% (por ejemplo, agregando dos comprimidos semanales) y controlar TSH en 4 semanas
D) Cambiar la levotiroxina por propiltiouracilo durante el primer trimestre
E) Reducir la dosis a la mitad para evitar inducir hipertiroidismo fetal

PREGUNTA 17 1.05.1.005, 4.01.1.013

17. ¿Cuál es el momento óptimo para la toma de la muestra de sangre en papel filtro para el tamizaje neonatal universal de hipotiroidismo congénito en Chile según la norma del Ministerio de Salud?

A) En sangre de cordón umbilical inmediatamente al momento del alumbramiento
B) En las primeras 6 horas de vida
C) Entre las 40 y 48 horas de vida, antes del alta de la maternidad
D) A los 7 días de vida en el primer control ambulatorio del recién nacido
E) Al mes de vida en el control de salud de la díada

PREGUNTA 18 1.03.2.004

18. Hombre de 55 años con hipercalcemia severa (Ca 13.5 mg/dL), náuseas, poliuria, confusión y deshidratación. PTH elevada. ¿Cuál es el tratamiento inicial de urgencia?

A) Resonancia magnética
B) Cintigrafía con sestamibi (localización de adenoma paratiroideo)
C) Hidratación EV con solución salina 0.9%
D) Paratiroidectomía de urgencia
E) Carbonato de calcio oral

BLOQUE 2 · BLOQUE 2 · TIROTOXICOSIS, BOCIO, NÓDULO Y CÁNCER DE TIROIDES

PREGUNTA 19 1.03.1.003

19. Mujer de 35 años con exoftalmo bilateral, palpitaciones, pérdida de peso y temblor fino en manos. TSH suprimida, T4 libre elevada. Bocio difuso. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Enfermedad de Graves-Basedow
B) Tiroiditis de Hashimoto
C) Bocio multinodular tóxico
D) Adenoma tóxico de tiroides
E) Tiroiditis subaguda de De Quervain

PREGUNTA 20 1.03.1.001

20. [ATENCIÓN PRIMARIA: Bocio · 1.03.1.001] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Bocio. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 21 1.03.1.004

21. [ATENCIÓN PRIMARIA: Cáncer del tiroides · 1.03.1.004] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Cáncer del tiroides. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 22 1.04.1.002

22. Una mujer de 32 años con diagnóstico de Enfermedad de Graves-Basedow inicia tratamiento con tiamazol 20 mg al día y propranolol 40 mg cada 8 horas. A las 3 semanas de haber iniciado el tratamiento, consulta en el servicio de urgencias por un cuadro de 24 horas de fiebre de 38.9°C, calofríos intensos y dolor faríngeo severo. Al examen físico se aprecia faringe congestiva con exudado amigdalino blanquecino y FC de 102 lpm. ¿Cuál es la conducta médica inmediata e inaplazable?

A) Iniciar amoxicilina con ácido clavulánico oral y citar a control en 48 horas
B) Suspender de inmediato el tiamazol, solicitar un hemograma urgente con recuento diferencial absoluto y hospitalizar en aislamiento
C) Duplicar la dosis de tiamazol a 40 mg/día por sospecha de reactivación tiroidea
D) Cambiar el tiamazol por propiltiouracilo a dosis equivalentes
E) Indicar paracetamol 1 g cada 8 horas y continuar el tiamazol sin modificaciones

PREGUNTA 23 1.04.1.002

23. Una paciente de 26 años con antecedente de Enfermedad de Graves-Basedow bien controlada con tiamazol 10 mg/día acude a control preconcepcional. Al examen se constata un bocio difuso indoloro sin signos inflamatorios. Su prueba de embarazo en orina resulta positiva, estimándose una gestación de 5 semanas. Su perfil hormonal muestra TSH 0.8 mIU/L y T4 libre 1.3 ng/dL. ¿Cuál es la conducta más adecuada respecto a su terapia antitiroidea durante este período?

A) Mantener el tiamazol a la misma dosis durante todo el embarazo por encontrarse eutiroidea
B) Suspender el tiamazol y cambiar inmediatamente a propiltiouracilo (PTU) a dosis equivalentes durante el primer trimestre
C) Suspender todos los antitiroideos y administrar de inmediato una dosis terapéutica de radioyodo I-131
D) Indicar tiroidectomía total de urgencia durante la semana 6 de gestación
E) Suspender todo tratamiento farmacológico y mantener únicamente observación sin controles hormonales

PREGUNTA 24 1.04.1.002

24. Un hombre de 68 años con antecedente de insuficiencia cardíaca consulta por palpitaciones de reposo, baja de 4 kg de peso en un mes y astenia. El electrocardiograma revela una fibrilación auricular de novo con respuesta ventricular de 135 lpm. La ecografía cervical no muestra nódulos ni bocio evidente y el examen oftalmológico es rigurosamente normal. Los exámenes revelan TSH < 0.01 mIU/L con T4 libre de 2.6 ng/dL. Los anticuerpos TRAb son negativos. El cintigrama tiroideo muestra captación focalizada e intensa en el polo inferior derecho con supresión funcional completa del resto del parénquima tiroideo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tiroiditis subaguda de De Quervain
B) Enfermedad de Graves-Basedow con variante atípica
C) Adenoma tóxico autónomo (enfermedad de Plummer unilocular)
D) Cáncer folicular de tiroides hiperfuncionante
E) Tirotoxicosis facticia por ingesta oculta de hormona tiroidea

PREGUNTA 25 1.04.1.002

25. **Una mujer de 35 años con Enfermedad de Graves-Basedow presenta recaída clínica y bioquímica tras haber completado 18 meses de terapia con tiamazol. Al examen físico destaca proptosis ocular moderada bilateral, quemosis conjuntival y diplopía al mirar hacia arriba, con test de actividad clínica orbitaria (CAS) de 4 puntos (enfermedad activa). Se plantea ablación tiroidea definitiva. ¿Cuál es la conducta terapéutica más apropiada para el manejo definitivo de su hipertiroidismo?**

A) Administrar dosis ablativa de radioyodo I-131 en monoterapia ambulatoria sin medicación previa

B) Tiroidectomía total previa preparación con tiamazol y yoduro inorgánico (Lugol), o en su defecto I-131 bajo estricta corticoterapia profiláctica sistémica

C) Suspender todo antitiroideo y manejar exclusivamente con propranolol oral

D) Indicar radioterapia orbitaria externa inmediata sin tocar la glándula tiroidea

E) Mantener tiamazol a dosis de 60 mg/día de por vida sin plantear terapia ablativa

PREGUNTA 26 1.04.1.002

26. **Una paciente de 42 años con antecedente de bocio multinodular tóxico de 45 g, sin síntomas compresivos, consulta para definir tratamiento curativo. La paciente tiene paridad completa y no tiene deseos de futuros embarazos. Se le propone tratamiento ablativo con radioyodo I-131. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a esta terapia es correcta?**

A) La probabilidad de remisión completa sin requerir levotiroxina es superior al 95%

B) El resultado esperado más frecuente a largo plazo es el hipotiroidismo permanente, el cual requiere suplementación de por vida

C) La paciente puede amamantar sin restricciones a su hijo lactante de 8 meses el día posterior al radioyodo

D) El I-131 está contraindicado porque los bocios multinodulares responden exclusivamente a tiamazol de por vida

E) El fármaco debe asociarse a dosis altas de aspirina para potenciar la fijación del isótopo

PREGUNTA 27 1.04.1.002

27. **Un paciente de 38 años con Enfermedad de Graves y un bocio difuso masivo de 120 gramos con compresión traqueal sintomática será sometido a una tiroidectomía total programada. Se encuentra actualmente eutiroideo bajo tratamiento con tiamazol 20 mg/día. Para minimizar el sangrado operatorio y reducir la vascularización de la glándula durante el acto quirúrgico, ¿cuál es la medida farmacológica preoperatoria recomendada en los 7 a 10 días previos a la cirugía?**

A) Indicar solución de Lugol (yoduro inorgánico) oral 3 a 5 gotas cada 8 horas

B) Suspender el tiamazol e iniciar propiltiouracilo a dosis altas

C) Administrar una dosis baja de radioyodo I-131 48 horas antes de la incisión

D) Indicar anticoagulación plena con heparina de bajo peso molecular

E) Administrar carbonato de litio para aumentar la captación de hormonas

PREGUNTA 28 1.03.2.001

28. **[URGENCIA: Tormenta tiroidea · 1.03.2.001] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Tormenta tiroidea. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 29 1.04.1.002

29. **Una mujer de 50 años con hipertiroidismo de Graves no controlado consulta en el servicio de urgencias por fiebre de 39.5°C, agitación psicomotora, náuseas, vómitos profusos y palpitaciones taquicárdicas. El electrocardiograma muestra taquicardia sinusal a 145 lpm y la escala de Burch-Wartofsky arroja 60 puntos, confirmando una tormenta tiroidea. ¿Cuál de las siguientes secuencias y combinaciones de fármacos representa el manejo médico correcto?**

A) Administrar ácido acetilsalicílico 1 g EV de inmediato, seguido de tiamazol 10 mg oral

B) Iniciar propranolol, propiltiouracilo a dosis altas, hidrocortisona endovenosa y posponer la solución de Lugol para administrarla al menos una hora después del propiltiouracilo

C) Administrar solución de Lugol en bolo endovenoso inmediato y continuar con levotiroxina en infusión

D) Indicar tiroidectomía total de urgencia en los primeros 30 minutos sin administración previa de fármacos

E) Administrar radioyodo I-131 a dosis máxima como terapia ablativa urgente

PREGUNTA 30 1.04.1.002

30. **En un paciente cursando una tormenta tiroidea con hipertermia severa de 40.2°C y compromiso sensorial en la unidad de cuidados intensivos, el residente de turno planea indicar un antipirético. ¿Cuál de los siguientes fármacos antipiréticos se encuentra FORMALMENTE CONTRAINDICADO por el riesgo inminente de incrementar las concentraciones plasmáticas de hormona tiroidea libre?**

A) Paracetamol

B) Dipirona (Metamizol)

C) Ácido acetilsalicílico (Aspirina)

D) Ibuprofeno

E) Ketorolaco

PREGUNTA 31 1.04.1.002

31. Un hombre de 45 años con antecedente de Enfermedad de Graves en abandono de tratamiento ingresa a urgencias con cuadro de shock distributivo, agitación extrema, diaforesis, ictericia y fibrilación auricular rápida a 160 lpm. Se diagnostica tormenta tiroidea con escala de Burch-Wartofsky de 65 puntos. ¿Cuál es el fundamento fisiopatológico fundamental por el cual se debe administrar Hidrocortisona endovenosa en el esquema inicial de rescate?

A) Para tratar la insuficiencia suprarrenal relativa por incremento acelerado del metabolismo del cortisol y frenar la conversión periférica de T4 a T3
B) Para inducir inmunosupresión inmediata de los anticuerpos TRAb en menos de 2 horas
C) Para elevar la TSH hipofisaria y restablecer el asa de retroalimentación
D) Para favorecer la captación folicular de yodo inorgánico
E) Para evitar la hipoglicemia provocada por el propiltiouracilo

PREGUNTA 32 1.04.1.002

32. En el protocolo de reanimación de la tormenta tiroidea, el orden cronológico de administración de los medicamentos es un aspecto técnico de máxima relevancia evaluado en EUNACOM. ¿Cuál es la razón biológica por la que se debe administrar el antitiroideo (propiltiouracilo) AL MENOS 60 minutos antes de administrar el yodo inorgánico (Lugol)?

A) Para evitar una reacción anafiláctica alérgica al yodo mediada por IgE
B) Para impedir que el yoduro exógeno sea utilizado como sustrato folicular para la síntesis de nuevas hormonas tiroideas (Fenómeno de Jod-Basedow)
C) Porque el yodo inorgánico inactiva químicamente al propiltiouracilo en la luz gástrica
D) Para asegurar la absorción duodenal previa del propranolol
E) Para prevenir la nefropatía por contraste inducida por tionamidas

PREGUNTA 33 1.03.1.021

33. Un paciente de 30 años, presenta un nódulo tiroideo, que en el examen físico se palpa de consistencia elástica, indoloro, sin adenopatías cervicales. Se solicita TSH: 0,2 UI/L (VN: 0,3 a 5,0 UI/L), con T4 y T3 normales. Se solicita ecografía cervical, que muestra un nódulo tiroideo sólido, redondo, de aspecto homogéneo, sin microcalcificaciones, de 3 cm de diámetro. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar cintigrafía tiroidea
B) Realizar punción con aguja fina
C) Controlar con pruebas tiroideas en 6 meses
D) Solicitar niveles de tiroglobulina
E) Realizar cirugía

PREGUNTA 34 1.04.1.003

34. Un hombre de 49 años se realiza un chequeo médico de medicina preventiva en el cual se pesquisa un nódulo tiroideo palpable de 1.8 cm en el polo inferior izquierdo. La TSH resulta en 2.1 mIU/L. La ecografía cervical informa un nódulo sólido, marcadamente hipoecogénico de 18 mm, con microcalcificaciones en su espesor y márgenes microlobulados, catalogado como ACR TI-RADS 5. No se identifican adenopatías patológicas. ¿Cuál es la conducta médica más adecuada a seguir?

A) Solicitar un cintigrama tiroideo con Tecnecio-99m para evaluar captación
B) Indicar Punción Aspirativa con Aguja Fina (PAAF) guiada por ecografía
C) Iniciar tratamiento supresor con levotiroxina 100 mcg/día para reducir el tamaño del nódulo
D) Indicar control ecográfico en 12 meses sin realizar biopsia
E) Administrar una dosis empírica de radioyodo I-131

PREGUNTA 35 1.04.1.003

35. Una mujer de 52 años consulta por un nódulo tiroideo solitario de 2.2 cm en el lóbulo derecho. Se solicita TSH que resulta en 0.05 mIU/L (suprimida) y T4 libre en 1.9 ng/dL. La paciente se encuentra oligoasintomática, con pulso de 88 lpm regular. ¿Cuál es el examen complementario de elección que debe realizarse a continuación para definir la conducta?

A) Punción aspirativa con aguja fina (PAAF) de inmediato
B) Resonancia magnética de cuello con contraste paramagnético
C) Cintigrama tiroideo con I-131 o Tc-99m
D) Determinación seriada de calcitonina sérica
E) Tomografía computarizada de tórax y cuello

PREGUNTA 36 1.04.1.003

36. Un paciente de 39 años es sometido a una PAAF guiada por ecografía de un nódulo tiroideo de 2.0 cm clasificado previamente como TI-RADS 4. El informe de la citopatología concluye: "Categoría Bethesda IV: Neoplasia Folicular / Sospecha de Neoplasia Folicular". El paciente no tiene antecedentes familiares ni factores de riesgo adicionales. ¿Cuál es la conducta terapéutica de elección indicada en este caso?

A) Observación clínica con ecografía de control a los 6 meses
B) Hemitiroidectomía (lobectomía más istmectomía) diagnóstica con estudio histopatológico definitivo diferido
C) Tiroidectomía total inmediata más vaciamiento ganglionar cervical radical bilateral
D) Tratamiento con radioyodo I-131 ambulatorio a dosis ablativa
E) Repetir la PAAF inmediatamente con aguja de mayor calibre (tru-cut)

BLOQUE 3 · BLOQUE 3 · CORTEZA Y MÉDULA SUPRARRENAL: CUSHING, ADDISON, CONN Y FEOCROMOCITOMA

PREGUNTA 37 1.03.1.008

37. Una paciente de 17 años, con antecedente se haber tenido su menarquia a los 16 años, con reglas que ocurren cada 3 a 4 meses. Tiene hirsutismo en el mentón, los brazos, el pecho, los muslos y la línea media abdominal, tanto infraumbilical, como supraumbilical, con un índice de Ferriman-Gallwey > 15. ¿Cuál es el examen de elección para hacer el diagnóstico diferencial con el síndrome de ovario poliquístico?

A) Relación FSH/LH
B) Cariograma
C) Curva de insulina
D) Prolactina
E) 17-hidroxi-progesterona

PREGUNTA 38 1.03.1.006

38. Una paciente de 28 años aumento de peso de 5 meses de evolución, asociado a malestar general. Refiere importante astenia, que ha progresado y debilidad muscular. Al examen físico presenta PA: 150/100 mmHg, atrofia de las masas musculares de las extremidades, obesidad abdominal y piel con estrías vinosas en la pared abdominal e hirsutismo en cara, abdomen y pecho. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio en este paciente?

A) Niveles de ACTH plasmático matinal y vespertino
B) 17 hidroxiprogesterona
C) TAC de silla turca
D) Cortisol libre urinario de 24 horas
E) Prueba de estimulación con ACTH

PREGUNTA 39 1.03.1.022

39. [ATENCIÓN PRIMARIA: Incidentaloma suprarrenal · 1.03.1.022] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Incidentaloma suprarrenal. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 40 1.04.1.005

40. Una mujer de 35 años consulta por obesidad central, debilidad muscular proximal, amenorrea de 6 meses y aparición de estrías violáceas anchas en abdomen. No refiere uso de fármacos. Se solicita un test de Nugent (1 mg dexametasona a las 23 h) que muestra cortisol matinal de 9.8 mcg/dL (no suprime) y un cortisol libre urinario en 24 horas elevado a 350 mcg (normal < 50 mcg/24h). ¿Cuál es el examen de elección que se debe solicitar a continuación para proseguir con el estudio etiológico?

A) Tomografía computarizada de abdomen y pelvis con protocolo suprarrenal
B) Determinación de niveles plasmáticos de hormona adrenocorticotropa (ACTH)
C) Resonancia magnética de silla turca con contraste
D) Cateterismo de senos petrosos inferiores
E) Cintigrama con octreótido marcado

PREGUNTA 41 1.04.1.005

41. Un hombre de 62 años, fumador pesado de 40 paquetes/año, consulta en urgencias por astenia severa, debilidad muscular profunda que le impide la bipedestación, edema de extremidades inferiores y pérdida de 8 kg de peso en el último mes. Al examen físico destaca hiperpigmentación cutánea difusa en zonas fotoexpuestas y pliegues, PA 175/105 mmHg, sin obesidad evidente. Los exámenes de laboratorio revelan glicemia de 260 mg/dL, sodio 144 mEq/L, potasio 2.1 mEq/L y bicarbonato de 36 mEq/L (alcalosis metabólica hipokalémica). Se confirma hipercortisolismo con ACTH plasmática marcadamente elevada en 280 pg/mL. El test de supresión con dosis alta de dexametasona (8 mg) no muestra supresión del cortisol. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Enfermedad de Cushing por adenoma hipofisario
B) Carcinoma de la corteza suprarrenal productor de cortisol
C) Síndrome de Cushing ectópico secundario a carcinoma pulmonar de células pequeñas (oat cell)
D) Hiperaldosteronismo primario (Síndrome de Conn)
E) Insuficiencia suprarrenal primaria por metástasis

PREGUNTA 42 1.04.1.005

42. Una paciente de 41 años con Síndrome de Cushing confirmado presenta una ACTH plasmática indetectable (< 2 pg/mL). La TC de abdomen revela un tumor suprarrenal derecho de 3.2 cm homogéneo con baja atenuación (< 10 Unidades Hounsfield) compatible con adenoma benigno; la glándula suprarrenal izquierda luce de aspecto atrófico y delgada. La paciente es sometida exitosamente a una suprarrenalectomía laparoscópica derecha. En el postoperatorio inmediato, ¿cuál es la medida farmacológica mandatoria que debe iniciarse para prevenir una complicación potencialmente mortal?

A) Iniciar ketoconazol oral para bloquear residuos tumorales
B) Iniciar terapia de reemplazo hormonal con Hidrocortisona por riesgo inminente de crisis suprarrenal secundaria a la atrofia del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal contralateral
C) Indicar espironolactona a dosis altas para prevenir hiperkalemia
D) Indicar radioyodo I-131 para destruir remanentes glandulares
E) Mantener en observación sin medicamentos puesto que la glándula contralateral asumirá de inmediato la función fisiológica

PREGUNTA 43 1.04.1.005

43. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de pruebas de laboratorio es la más apropiada y aceptada por el consenso internacional como PRIMERA LÍNEA para pesquisar y confirmar la presencia de hipercortisolismo endógeno en un paciente con sospecha clínica de Síndrome de Cushing?

A) Cortisol plasmático basal a las 08:00 h y ACTH plasmática basal
B) Test de supresión rápida con dexametasona 1 mg nocturno (Nugent), Cortisol Libre Urinario en 24 horas y Cortisol salival nocturno
C) Test de dexametasona 8 mg y Tomografía computarizada de glándulas suprarrenales
D) Medición de metabolitos urinarios 17-hidroxicorticosteroides y 17-cetosteroides
E) Test de estimulación con ACTH sintética (Synacthen) 250 mcg

PREGUNTA 44 1.03.1.007

44. **Un paciente alcohólico, vagabundo, con antecedente de haber sido tratado por tuberculosis hace dos años, consulta por un cuadro de diarrea y baja de peso, malestar general de algunos meses de evolución. En su examen físico se aprecia IMC de 16, hiperpigmentación de pliegues y melanoplaquias. En sus exámenes tiene K: 5,5 mEq/L, Na: 132 mEq/L. El diagnóstico más probable es:**

A) Síndrome paraneoplásico
B) Desnutrición proteica
C) Enfermedad de Addison
D) Cáncer de sitio no precisado
E) Pancreatitis crónica

PREGUNTA 45 1.03.1.019

45. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Osteoporosis secundaria · 1.03.1.019] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Osteoporosis secundaria. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 46 1.03.2.003

46. **Un paciente tiene diarrea de 3 días de evolución, asociada a malestar general marcado y vómitos alimentarios, con deterioro del estado general. Al examen físico se observa deshidratado, con FC: 110 x', PA: 70/40 mmHg, abdomen doloroso, sin irritación peritoneal. Se solicitan exámenes, entre los que destacan Na+: 126 mEq/L, K+: 4,7 mEq/L, glicemia: 58 mg/dl, PCR: 4,0, blancos: 12.000 por mm3, creatinina 2,3 mg/dl. Se administran 3 litros de suero fisiológico, sin lograr estabilizar al paciente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Insuficiencia renal aguda
B) Shigelosis
C) Peritonitis aguda
D) Insuficiencia suprarrenal aguda
E) Accidente vascular hemorrágico

PREGUNTA 47 1.04.1.006

47. **Un hombre de 42 años acude a la consulta médica por debilidad marcada, náuseas recurrentes, baja de 6 kg de peso e hipotensión arterial. Al examen físico destaca hiperpigmentación marcada en surcos de las manos, codos y encías. Sus exámenes demuestran Na+ 129 mEq/L, K+ 5.8 mEq/L y glicemia de 70 mg/dL. El cortisol basal a las 08:00 h resulta en 2.0 mcg/dL con ACTH plasmática de 180 pg/mL (VN < 50). ¿Cuál es el tratamiento sustitutivo crónico de elección que debe prescribirse?**

A) Hidrocortisona oral en monoterapia
B) Prednisona oral asociada a espironolactona
C) Hidrocortisona oral asociada obligatoriamente a Fludrocortisona oral
D) Dexametasona oral en dosis nocturna única
E) Fludrocortisona oral en monoterapia sin glucocorticoides

PREGUNTA 48 1.04.1.006

48. **Una mujer de 58 años con antecedente de artritis reumatoide en tratamiento crónico con prednisona 15 mg diarios durante 2 años decide suspender bruscamente el fármaco por cuenta propia. A los 5 días consulta en el policlínico por debilidad extrema, náuseas, astenia e hipotensión postural (PA 95/60 mmHg). Se constata piel pálida sin hiperpigmentación. El laboratorio muestra Na+ 131 mEq/L, K+ 4.2 mEq/L, ACTH de 4 pg/mL y cortisol de 2.1 mcg/dL. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal que explica este cuadro?**

A) Destrucción autoinmune aguda de la glándula suprarrenal
B) Supresión exógena prolongada del eje hipotálamo-hipófisis con atrofia corticosuprarrenal secundaria y déficit exclusivo de glucocorticoides con aldosterona preservada
C) Falla mineralocorticoide primaria con pérdida renal masiva de potasio
D) Secreción ectópica de péptidos suresores adrenales
E) Síndrome de lisis corticosuprarrenal por nefropatía intersticial

PREGUNTA 49 1.04.1.006

49. **Un paciente de 45 años con antecedente de Enfermedad de Addison en tratamiento con hidrocortisona y fludrocortisona presenta neumonía bacteriana adquirida en la comunidad. Ingresa a la urgencia estuporoso, pálido, sudoroso, con PA 65/40 mmHg y FC 128 lpm. El hemoglucotest marca 52 mg/dL. Tras recibir 2000 mL de suero fisiológico en 45 minutos, la presión arterial se mantiene en 70/45 mmHg. ¿Cuál es la medida farmacológica inmediata de máxima prioridad para revertir este estado hemodinámico?**

A) Iniciar infusión de dopamina a dosis inotrópica
B) Iniciar infusión continua de noradrenalina a dosis altas
C) Administrar Hidrocortisona 100 mg en bolo endovenoso directo
D) Administrar fludrocortisona 1 mg por sonda nasogástrica
E) Realizar pericardiocentesis de urgencia

PREGUNTA 50 1.04.1.006

50. Un lactante de 2 semanas de vida es traído a urgencias en estado de shock severo, deshidratación grave, letargia y vómitos explosivos. El ionograma plasmático urgente revela Na+ 118 mEq/L y K+ 7.8 mEq/L con acidosis metabólica severa. Al examen físico destaca hiperpigmentación de los genitales externos y escroto rugoso hiperpigmentado. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica prioritaria y el tratamiento médico urgente que debe instaurarse sin demora?

A) Estenosis hipertrófica del píloro; resolución quirúrgica de urgencia
B) Hiperplasia suprarrenal congénita perdedora de sal (déficit de 21-hidroxilasa); rescate urgente con Hidrocortisona endovenosa y solución salina fisiológica
C) Sepsis por Pseudomonas aeruginosa; ceftazidima en bolo
D) Insuficiencia renal aguda anúrica; hemodiálisis de emergencia
E) Síndrome urémico hemolítico; transfusión de glóbulos rojos lavados

PREGUNTA 51 1.04.1.006

51. En un servicio de urgencias ingresa un paciente con alta sospecha de crisis suprarrenal aguda en shock hipotensivo. El médico de turno solicita una muestra de sangre para cortisol y electrolitos. ¿Cuál es la conducta médica correcta respecto al inicio de la Hidrocortisona endovenosa?

A) Esperar el resultado analítico del cortisol plasmático en sangre para confirmar el diagnóstico antes de inyectar el corticoide
B) Extraer la muestra de sangre e iniciar INMEDIATAMENTE el bolo de Hidrocortisona 100 mg EV sin esperar el resultado del laboratorio
C) Esperar la realización de una ecografía suprarrenal previa para descartar hemorragia adrenal
D) Iniciar antibióticos de amplio espectro y diferir los corticoides hasta las 12 horas de evolución
E) Administrar solución salina exclusiva y esperar 6 horas de respuesta hemodinámica

PREGUNTA 52 1.04.1.006

52. ¿Por qué razón farmacológica y fisiológica NO es necesario administrar Fludrocortisona (mineralocorticoide) durante la fase aguda de reanimación en una crisis suprarrenal manejada con Hidrocortisona a dosis altas (100 mg cada 6 a 8 horas)?

A) Porque la fludrocortisona solo se absorbe por vía rectal
B) Porque a dosis iguales o superiores a 50-100 mg/día, la hidrocortisona satura el receptor mineralocorticoide proporcionando una actividad mineralocorticoide plenamente suficiente
C) Porque la aldosterona se encuentra siempre elevada en la crisis suprarrenal
D) Porque la fludrocortisona empeora la hipoglicemia aguda
E) Porque los mineralocorticoides están contraindicados si la presión arterial sistólica es menor a 90 mmHg

PREGUNTA 53 1.04.1.007

53. Un hombre de 34 años con diagnóstico reciente de hipertensión arterial severa (PA 170/110 mmHg) presenta debilidad muscular episódica y calambres. En los exámenes de laboratorio se constata hipokalemia de 2.9 mEq/L sin uso previo de diuréticos. Se sospecha hiperaldosteronismo primario. ¿Cuál es el examen de tamizaje de primera línea que debe solicitarse para confirmar la sospecha diagnóstica?

A) Determinación de cortisol libre urinario en 24 horas
B) Medición simultánea de la relación aldosterona plasmática / actividad de renina plasmática (RAR)
C) Tomografía computarizada de glándulas suprarrenales con contraste
D) Angiografía de arterias renales
E) Metanefrinas libres en plasma

PREGUNTA 54 1.04.1.007

54. Una paciente de 48 años con hipertensión arterial de difícil manejo y relación aldosterona/renina elevada es sometida a un estudio etiológico completo que demuestra una Hiperplasia Suprarrenal Bilateral Idiopática. No es candidata a cirugía. ¿Cuál es el tratamiento médico farmacológico de primera elección para controlar su hipertensión y normalizar el potasio sérico?

A) Suprarrenalectomía bilateral total inmediata
B) Espironolactona oral
C) Furosemida en dosis altas
D) Aliskiren (inhibidor directo de la renina)
E) Hidralazina asociada a minoxidil

BLOQUE 4 · METABOLISMO MINERAL, CALCIO, PARATIROIDES Y HUESO

PREGUNTA 55 1.03.1.020

55. Un paciente de 32 años, con antecedente de litiasis renal a repetición se realiza exámenes, que muestran calcio plasmático: 9,8 mg/dl, albúmina: 3,0 g/dl, creatinina plasmática: 0,7 mg/dl, PTH: 90 UI/L (VN: 10 a 55 pg/ml) y calciuria de 200 mg/día (VN: 50 a 150 mg/día) . El diagnóstico más probable es:

A) Hiperparatiroidismo primario
B) Hiperparatiroidismo secundario
C) Hiperparatiroidismo terciario
D) Hipercalciuria primaria
E) Hipercalciuria familiar

PREGUNTA 56 1.03.1.020

56. En el estudio de una osteoporosis de una paciente, se pesquisa tiene calcemia de 11 mg/dl, niveles de paratohormona de 155 UI/L (VN: 15 a 55), niveles de vitamina D: (VN:) y albúmina de 3,8 g/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hipercalcemia idiopática
B) Hiperparatiroidismo primario
C) Hiperparatiroidismo secundario
D) Hiperparatiroidismo terciario
E) Hipercalcemia familiar

PREGUNTA 57 1.03.1.020

57. Mujer de 58 años con calcio sérico de 11.8 mg/dL detectado en examen de rutina. Asintomática. Sin uso de suplementos de calcio ni vitamina D. ¿Cuál es el estudio inicial de elección para determinar la causa de la hipercalcemia?

A) PTH sérica
B) Fósforo sérico
C) Calcitonina
D) Calcio en orina de 24h
E) Vitamina D (25-OH)

PREGUNTA 58 1.03.1.020

58. Hombre de 55 años asintomático con calcio sérico 11.2 mg/dL, fósforo 2.1 mg/dL (bajo) y PTH 145 pg/mL (elevada). Sin otros hallazgos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hiperparatiroidismo primario
B) Hipercalcemia hipocalciúrica familiar
C) Hipercalcemia de malignidad
D) Intoxicación por vitamina D
E) Sarcoidosis

PREGUNTA 59 1.03.1.020

59. Paciente de 63 años, con antecedente de hipernefroma operado hace un año, con buena evolución, consulta por cuadro de astenia y debilidad de 7 días, controlándose exámenes de sangre entre los que destaca calcemia de 11,8 mg/dL (valor normal 8,5-10,5 mg/dL), albúmina normal. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio de este paciente?

A) Cintigrafía ósea
B) Niveles plasmáticos de calcio y paratohormona
C) TAC de abdomen y pelvis
D) Niveles plasmáticos de vitamina D
E) Resonancia magnética de abdomen y pelvis

PREGUNTA 60 1.03.1.020

60. Un paciente de 67 años consulta por dolores óseos en múltiples zonas. Se realiza exámenes, entre los que destaca calcemia corregida de 14,4 mg/dl, con pruebas de función renal normales. Además, se solicitan radiografías que muestran imágenes sugerentes de metástasis óseas. ¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?

A) Calciuria de 24 horas
B) Niveles plasmáticos de 25-OH vitamina D
C) Niveles plasmáticos de paratohormona
D) Cintigrafía ósea
E) Niveles plasmáticos de calcio iónico

PREGUNTA 61 1.03.2.005

61. Paciente con tiroidectomía total e hipoparatiroidismo, presenta debilidad, parestesias y signo de Chvostek positivo. ¿Cuál es el tratamiento inicial?

A) Calcitriol oral más calcio oral
B) Gluconato de calcio endovenoso
C) Carbonato de calcio 1 g oral
D) PTH recombinante subcutáneo
E) Terlipresina endovenosa

PREGUNTA 62 1.04.1.009

62. Un paciente de 64 años con antecedente de cáncer epidermoide de pulmón en etapa avanzada ingresa al servicio de urgencias estuporoso, con sequedad extrema de mucosas, deshidratación severa y signos clínicos de shock hipovolémico. El laboratorio de urgencia revela: Calcio plasmático de 15.2 mg/dL con albúmina de 3.0 g/dL (calcio corregido de 16.0 mg/dL), creatinina de 2.8 mg/dL y una PTH intacta suprimida en 4 pg/mL. El electrocardiograma muestra un intervalo QT marcadamente acortado. ¿Cuál es la primera medida terapéutica de máxima prioridad que debe iniciarse de inmediato?

A) Infusión endovenosa rápida de furosemida a dosis de 80 mg en bolo
B) Hidratación agresiva con Suero Fisiológico al 0.9% en infusión endovenosa continua de 200 a 300 mL/hora
C) Calcitonina de salmón subcutánea en monoterapia
D) Ácido zoledrónico 4 mg EV en bolo rápido sin hidratación previa
E) Fosfato de potasio endovenoso

PREGUNTA 63 1.04.1.009

63. Una paciente de 46 años asintomática acude a control de salud. En un perfil bioquímico preventivo se detecta calcio sérico de 11.2 mg/dL con albúmina de 4.0 g/dL. El médico sospecha hiperparatiroidismo primario. ¿Cuál es el examen de laboratorio indispensable que confirmará esta sospecha diagnóstica al demostrar su valor elevado o inapropiadamente normal?

A) Hormona Paratiroidea Intacta (PTHi)
B) Péptido relacionado con la PTH (PTHrP)
C) Calcitriol sérico (1,25-dihidroxivitamina D)
D) Calcitonina plasmática
E) Fosfatasas alcalinas óseas

PREGUNTA 64 1.04.1.009

64. Una mujer de 44 años asintomática presenta hiperparatiroidismo primario confirmado con calcio corregido de 11.8 mg/dL y PTHi de 110 pg/mL. La densitometría ósea muestra un T-score de -2.7 en columna lumbar y la ecografía renal pesquisó microlitiasis renal asintomática. La paciente consulta si debe intervenirse quirúrgicamente. ¿Cuál es la indicación médica correcta respecto a la cirugía paratiroidea?

A) No cumple criterios quirúrgicos por encontrarse asintomática; mantener control anual exclusivo con densitometría
B) Cumple criterios formales de Paratiroidectomía debido a su edad menor de 50 años, nivel de calcio > 1 mg/dL sobre el límite normal, presencia de osteoporosis (T-score < -2.5) y litiasis renal
C) Debe recibir radioterapia cervical externa en lugar de cirugía
D) Debe indicarse tratamiento de por vida con cinacalcet y suspender todo lácteo
E) La cirugía está contraindicada porque los adenomas paratiroideos regresionan espontáneamente

PREGUNTA 65 1.04.1.009

65. Un paciente de 52 años sometido a una paratiroidectomía subtotal exitosa por hiperparatiroidismo primario severo con compromiso óseo extenso presenta al tercer día postoperatorio parestesias periorales intensas, signo de Chvostek positivo, espasmo carpopedal (signo de Trousseau) y calcio plasmático de 6.4 mg/dL con fósforo sérico de 1.8 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico de esta complicación postquirúrgica clásica?

A) Síndrome del Hueso Hambriento (Hungry Bone Syndrome)
B) Hipotiroidismo iatrogénico agudo
C) Falla renal aguda por nefropatía de contraste
D) Pseudohipoparatiroidismo tipo 1A
E) Crisis tirotóxica por manipulación cervical

PREGUNTA 66 1.04.1.010

66. Una paciente de 42 años intervenida de tiroidectomía total hace 48 horas presenta parestesias periorales, contractura muscular dolorosa en ambas manos al inflar el manguito de presión arterial (signo de Trousseau positivo) y sensación de falta de aire con estridor inspiratorio leve. El laboratorio urgente confirma un calcio plasmático de 6.1 mg/dL. ¿Cuál es la conducta terapéutica inmediata más adecuada?

A) Administrar carbonato de calcio 1 g por vía oral y citar a control en 24 horas
B) Administrar una ampolla de Gluconato de Calcio al 10% por vía endovenosa lenta en 10 a 20 minutos bajo monitorización cardíaca
C) Administrar vitamina D3 (colecalciferol) 100.000 UI en dosis oral única
D) Indicar rebreathing con bolsa de papel para aumentar la pCO2
E) Administrar cloruro de potasio en bolo endovenoso rápido

PREGUNTA 67 1.04.1.010

67. Un paciente alcohólico crónico de 54 años ingresa desnutrido con tetania muscular y parestesias. El calcio sérico es de 6.8 mg/dL. Pese a recibir dos bolos endovenosos consecutivos de gluconato de calcio, el paciente persiste tetánico con calcio sérico en 6.9 mg/dL. ¿Cuál es el examen de laboratorio que debe solicitarse de inmediato para identificar la causa de la refractariedad terapéutica?

A) Magnesemia plasmática
B) Calcitonina sérica
C) TSH sérica
D) Ácido fólico plasmático
E) Plomo en sangre

PREGUNTA 68 1.03.1.018

68. Una paciente de 65 años, en tratamiento con calcio 2 gramos al día y vitamina D, 600 UI al día, se realiza una densitometría ósea que muestra un T score de -2,7 en la cadera derecha y de -2,8 en la columna lumbar. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Indicar ejercicio aeróbico
B) Indicar reposo relativo
C) Aumentar dosis de vitamina D y calcio
D) Agregar bifosfonatos al tratamiento
E) Mantener el tratamiento

PREGUNTA 69 1.04.1.011

69. Una mujer de 71 años presenta una fractura del cuello femoral izquierdo tras resbalar y caer desde su propia altura en el living de su casa. En el postoperatorio de la osteosíntesis, la densitometría ósea informa un T-score de -2.2 DE en columna lumbar y -2.1 DE en cadera contralateral (osteopenia). ¿Cuál es la conducta terapéutica correcta respecto a su salud ósea?

A) No iniciar fármacos antiosteoporóticos específicos debido a que el T-score no alcanza el umbral de -2.5 DE
B) Iniciar tratamiento farmacológico antiosteoporótico con bifosfonatos (o ácido zoledrónico) asociado a calcio y vitamina D, debido a que la fractura por fragilidad establece el diagnóstico clínico directo de osteoporosis
C) Indicar reposo absoluto en cama por 6 meses para favorecer la consolidación ósea
D) Administrar calcitonina nasal como único tratamiento durante 5 años
E) Citar a nueva densitometría en 2 años para reevaluar la indicación de fármacos

PREGUNTA 70 1.04.1.011

70. Una paciente de 66 años con osteoporosis densitométrica (T-score -2.9 en columna lumbar) inicia tratamiento con Alendronato 70 mg una vez a la semana por vía oral. Para maximizar la absorción del medicamento y minimizar el riesgo de esofagitis erosiva medicamentosa severa, ¿cuál de las siguientes indicaciones de administración debe entregarse a la paciente?

A) Ingerir el comprimido por la noche inmediatamente antes de acostarse junto a un vaso de leche entera
B) Tomar el comprimido en ayuno absoluto matinal con un vaso lleno de agua pura de la llave y mantenerse sentada o de pie sin acostarse durante al menos 30 minutos
C) Masticar el comprimido junto con el desayuno matinal para facilitar su deglución
D) Disolver el comprimido en jugo de naranja cítrico para favorecer su solubilidad ácida
E) Tomar el comprimido junto a las sales de calcio para que se absorban de manera conjunta

PREGUNTA 71 1.04.1.012

71. Un médico de atención primaria atiende a una mujer de 82 años institucionalizada en un hogar de ancianos sin exposición a luz solar. Para evaluar el estado de sus reservas corporales de vitamina D y descartar deficiencia nutricional, ¿cuál es el examen de laboratorio específico que debe solicitarse?

A) 1,25-dihidroxivitamina D sérica (Calcitriol)
B) 25-hidroxivitamina D sérica [25(OH)D o Calcidiol]
C) Calcitonina sérica basal
D) Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S)
E) Fosfatasas alcalinas leucocitarias

PREGUNTA 72 1.04.1.012

72. **Una paciente de 75 años con dolor óseo sordo progresivo y debilidad muscular proximal presenta en sus exámenes de sangre: Calcio 8.5 mg/dL, Fósforo 2.0 mg/dL, Fosfatasas Alcalinas elevadas en 380 U/L (VN < 120), PTH intacta de 120 pg/mL y una 25-hidroxivitamina D de 7 ng/mL. Las radiografías revelan seudofracturas en ramas isquiopubianas. Se concluye Osteomalacia por déficit severo de vitamina D. ¿Cuál es el esquema farmacológico de ataque más apropiado?**

A) Colecalciferol 50.000 UI por vía oral una vez a la semana durante 8 semanas, asociado a suplementación con calcio elemental
B) Ácido zoledrónico 5 mg endovenoso en dosis única
C) Alendronato 70 mg semanal en monoterapia
D) Teriparatida 20 mcg subcutáneo diario sin vitamina D
E) Calcitonina nasal 200 UI diarias

BLOQUE 5 · BLOQUE 5 · HIPÓFISIS, HIPOTÁLAMO, NEUROENDOCRINOLOGÍA Y MEN

PREGUNTA 73 1.03.1.010

73. **Una paciente de 22 años consulta por amenorrea de 4 meses de evolución, sin otras alteraciones. Se realiza exámenes, que muestran test de embarazo negativo, TSH y prolactina, que están dentro de rangos normales. Se solicita prueba de progesterona, que resulta negativa y prueba de estrógeno y progesterona, que resulta positiva. Además, se solicita LH y FSH, que están normales, dentro del límite bajo. El diagnóstico más probable es:**

A) Prolactinoma
B) Falla ovárica primaria
C) Embarazo ectópico
D) Amenorrea hipotalámica
E) Síndrome de ovario poliquístico

PREGUNTA 74 1.03.1.012

74. **Un paciente de 32 años consulta por un cuadro de disfunción sexual asociado a disminución del vello facial. Al examen físico presenta disminución del vello corporal y disminución del tamaño testicular bilateral. ¿Cuál es el estudio más adecuado para proseguir el enfrentamiento de este paciente?**

A) Prolactina
B) Testosterona y LH
C) Espermiograma y FSH
D) Ecografía testicular
E) HCG y estradiol

PREGUNTA 75 1.03.1.023

75. **Adolescente masculino de 14 años con aumento bilateral del tejido mamario subareolar, sensible al tacto, sin secreción. Sin medicamentos. Desarrollo puberal Tanner 3. ¿Cuál es el diagnóstico y conducta?**

A) Ginecomastia puberal fisiológica; tranquilizar y observar
B) Cáncer de mama masculino; biopsia urgente
C) Hiperprolactinemia; solicitar prolactina
D) Hipogonadismo; solicitar testosterona
E) Tumor testicular; solicitar ecografía testicular

PREGUNTA 76 1.03.1.009

76. **Una paciente de 60 años presenta cefalea, astenia y calambres en extremidades inferiores. Al examen físico destaca PA: 170/95 mmHg, FC: 80 lpm y en sus exámenes destaca Na: 150 mEq/L, K:2.6 mEq/L, Cl:90 mEq/L y TSH: 4.0 UI/L. La causa más probable de la hipertensión es:**

A) Hipertensión renovascular
B) Feocromocitoma
C) Hipotiroidismo
D) Hiperaldosteronismo
E) Hipertensión esencial

PREGUNTA 77 1.03.1.013

77. **Un paciente presenta astenia y aumento de tamaño de la mandíbula, con separación entre los dientes. Además refiere hipertrofia malar, de la nariz y las manos. También ha aumentado el número de sus zapatos. ¿Qué examen es más adecuado para continuar el estudio de este paciente?**

A) Niveles de hormona de crecimiento
B) Radiografías de pies y de la arcada dentaria
C) Radiografía de manos
D) Niveles de IGF-1
E) Resonancia magnética de hipófisis

PREGUNTA 78 1.04.1.013

78. **Un paciente de 52 años consulta por cefalea progresiva. La campimetría visual computarizada demuestra una hemianopsia bitemporal. La RM de cerebro revela una masa intraselar con extensión supraselar de 24 mm que comprime el quiasma óptico. El perfil hormonal descarta hiperprolactinemia (prolactina normal) y no hay hipersecreción de GH ni ACTH. ¿Cuál es el tratamiento de elección indicado para descomprimir la vía óptica y evitar la ceguera permanente?**

A) Iniciar cabergolina oral a dosis altas
B) Cirugía de resección transesfenoidal del macroadenoma
C) Radioterapia holocraneana convencional
D) Tratamiento con temozolomida
E) Observación con control campimétrico en 6 meses

PREGUNTA 79 1.04.1.013

79. Un hombre de 45 años con antecedente de cefaleas esporádicas consulta en el servicio de urgencias por inicio súbito hace 3 horas de cefalea holocraneana de intensidad 10/10 en 'estallido', acompañada de vómitos, caída del párpado superior derecho (ptosis palpebral), diplopía y marcada somnolencia. Al examen físico destaca PA 85/50 mmHg, FC 62 lpm, parálisis completa del tercer par craneal derecho con midriasis y defecto campimétrico bitemporal severo. La TC de cerebro muestra una masa selar heterogénea con focos hiperdensos compatibles con hemorragia aguda intraselar. ¿Cuál es la medida médica farmacológica inicial de máxima prioridad que debe administrarse de inmediato?

A) Manitol al 20% en infusión rápida
B) Hidrocortisona 100 mg endovenosa directa en bolo
C) Cabergolina por sonda nasogástrica
D) Heparina de bajo peso molecular subcutánea
E) Somatostatina endovenosa continua

PREGUNTA 80 1.03.1.016

80. Una paciente de 38 años, usuaria de anticonceptivos combinados orales, desde hace 4 meses, consulta por galactorrea de algunas semanas de evolución, sin otros síntomas. Las mamas se palpan sin nódulos y se objetiva la galactorrea al comprimir las mamas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar niveles de progesterona
B) Solicitar niveles de prolactina
C) Cambiar los anticonceptivos a progestágenos solos
D) Solicitar TAC de cerebro
E) Solicitar niveles plasmáticos de estradiol, LH y FSH

PREGUNTA 81 1.04.1.014

81. Una paciente de 28 años consulta por amenorrea de 6 meses y galactorrea bilateral. La prueba de embarazo es negativa y la TSH es de 1.9 mIU/L. La prolactina sérica resulta en 180 ng/mL. La RM de cerebro confirma un prolactinoma de 8 mm intraselar. La paciente no toma medicamentos y desea recuperar sus ciclos menstruales para buscar un embarazo. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea de elección que debe indicarse?

A) Resección quirúrgica por vía transesfenoidal de inmediato
B) Terapia médica oral con Cabergolina (agonista dopaminérgico)
C) Radiocirugía estereotáxica con Gamma Knife
D) Anticonceptivos orales combinados para inducir sangrado
E) Reemplazo con levotiroxina en dosis supresiva

PREGUNTA 82 1.04.1.014

82. Una paciente de 34 años con antecedente de esquizofrenia en tratamiento regular con risperidona 4 mg al día desde hace un año consulta por ausencia de menstruaciones de 4 meses y galactorrea bilateral leve. No presenta cefalea ni alteraciones visuales. La prueba de embarazo es negativa. La prolactina plasmática resulta en 58 ng/mL y la TSH es normal. ¿Cuál es la causa más probable de su hiperprolactinemia y amenorrea?

A) Macroprolactinoma hipofisario invasor
B) Efecto adverso farmacológico por bloqueo de receptores dopaminérgicos D2 en la vía tuberoinfundibular inducido por risperidona
C) Insuficiencia ovárica primaria autoinmune precoz
D) Síndrome de Sheehan asintomático
E) Carcinoma corticosuprarrenal ectópico

PREGUNTA 83 1.04.1.015

83. Un paciente de 48 años consulta por sudoración profusa, ensanchamiento progresivo de manos y pies y síndrome de apnea obstructiva del sueño. El médico sospecha acromegalia. ¿Cuál es el examen de tamizaje de primera línea que debe solicitarse para evaluar la presencia de esta patología?

A) Determinación aislada de hormona de crecimiento (GH) plasmática matinal en ayunas
B) Factor de crecimiento insulínico tipo 1 sérico (IGF-1 o somatomedina C)
C) Tomografía computarizada de cerebro sin contraste
D) Radiografía de manos para evaluar espolones óseos
E) Prueba de estimulación con GHRH

PREGUNTA 84 1.04.1.015

84. En un paciente con alta sospecha clínica de acromegalia y niveles séricos de IGF-1 elevados para su rango etario, ¿cuál es la prueba de confirmación diagnóstica estándar de oro que debe realizarse para demostrar la secreción autónoma de hormona de crecimiento?

A) Test de tolerancia a la sobrecarga oral con 75 gramos de glucosa (PTGO) con medición seriada de GH
B) Test de hipoglicemia inducida por insulina
C) Medición seriada de prolactina cada 15 minutos
D) Test de supresión con dexametasona 8 mg
E) Biopsia estereotáxica transcraneal

PREGUNTA 85 1.03.1.014

85. Una paciente de 28 años, se realiza una histerectomía postparto, por una inercia uterina. Usted la atiende 6 meses después, sin lactancia y permaneciendo en amenorrea. Presenta un cuadro de astenia, adinamia y malestar general, asociada a debilidad. Tiene piel seca, con cabello quebradizo, palidez y su presión arterial es de 90/60 mmHg. El diagnóstico más probable es:

A) Tiroiditis postparto
B) Panhipopituitarismo
C) Depresión postparto
D) Insuficiencia ovárica
E) Hipotiroidismo

PREGUNTA 86 1.04.1.016

86. **Una paciente de 35 años con antecedente de shock hipovolémico por hemorragia del alumbramiento hace 1 año presenta fracaso de lactancia, amenorrea persistente, astenia extrema e hipotensión. Se confirma panhipopituitarismo por Síndrome de Sheehan con T4 libre y cortisol plasmático severamente disminuidos. Respecto al inicio de su terapia de reemplazo hormonal, ¿cuál es la regla de seguridad cronológica obligatoria que debe respetarse?**

A) Iniciar levotiroxina a dosis plenas de inmediato y posponer los glucocorticoides hasta que la TSH se normalice
B) Iniciar tratamiento glucocorticoide con Hidrocortisona en primer lugar, y solo después de 24 a 48 horas comenzar la sustitución con Levotiroxina
C) Iniciar estrógenos orales antes que cualquier otra hormona para proteger la masa ósea
D) Administrar hormona de crecimiento humana recombinante en monoterapia
E) No iniciar medicamentos hormonales y derivar a fisioterapia

PREGUNTA 87 1.04.1.016

87. **Una mujer de 42 años diagnosticada de hipopituitarismo secundario a la resección de un macroadenoma selar se encuentra en tratamiento de reemplazo con levotiroxina 100 mcg/día e hidrocortisona 20 mg/día. Acude a su primer control ambulatorio. ¿Cuál es el examen de laboratorio adecuado que debe solicitarse para titular y ajustar la dosis de levotiroxina en esta paciente?**

A) TSH sérica ultrasensible exclusivamente
B) T4 libre plasmática
C) T3 reversa plasmática
D) Anticuerpos anti-TPO
E) Tiroglobulina sérica

PREGUNTA 88 1.03.1.015

88. **Niño operado de cirugía cerebral, luego presenta hipernatremia y poliuria. ¿Diagnóstico más probable?**

A) Síndrome de secreción inadecuada de ADH (SIADH)
B) Diabetes mellitus tipo 1
C) Hiperaldosteronismo secundario
D) Diabetes insípida central
E) Polidipsia psicogénica

PREGUNTA 89 1.04.1.017

89. **Un paciente de 25 años sometido a la extirpación quirúrgica de un craneofaringioma supraselar presenta en el postoperatorio inmediato una diuresis abrupta de 600 mL/hora durante 4 horas consecutivas. El laboratorio demuestra una densidad urinaria de 1.002, osmolaridad urinaria de 110 mOsm/kg y una natremia que asciende rápidamente a 152 mEq/L. Tras la administración de 2 mcg de Desmopresina (DDAVP) por vía subcutánea, la diuresis disminuye a 80 mL/hora y la osmolaridad urinaria se eleva a 520 mOsm/kg. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Síndrome de pérdida cerebral de sal
B) Diabetes Insípida Central aguda postquirúrgica
C) Diabetes Insípida Nefrogénica
D) Diuresis osmótica por hiperglicemia
E) Síndrome de secreción inadecuada de ADH

PREGUNTA 90 1.04.1.017

90. **Una paciente de 32 años consulta para asesoramiento genético. Refiere que a su madre le diagnosticaron hiperparatiroidismo primario por adenomas en múltiples glándulas paratiroides y que a su hermano le extirparon un prolactinoma hipofisario y un tumor neuroendocrino pancreático productor de gastrina (gastrinoma). ¿Cuál de los siguientes genes es el responsable más probable de esta agregación familiar de neoplasias endocrinas múltiples?**

A) Protooncogén RET
B) Gen supresor de tumores MEN1 (Menina)
C) Gen supresor tumoral VHL
D) Gen NF1
E) Gen del receptor de TSH

SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

BLOQUE 1 PATOLOGÍA TIROIDEA FUNCIONAL: HIPOTIROIDISMO Y TIROIDITIS · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 1 Respuesta: D

1.03.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo

El hipotiroidismo se caracteriza por la piel seca. El mixedema pretibial y exoftalmo son de la enfermedad de Basedow Graves, las melanoplaquias de la enfermedad de Addison y la acantosis nigricans, de la resistencia a la insulina.

PREGUNTA 2 Respuesta: B

1.03.1.005 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo

Tiene una tiroiditis subaguda de Quervain, cuyo tratamiento son los AINEs. No se usan las drogas antitiroideas y no sirve el yodo radiactivo (de hecho, no capta). El betabloqueo sí se usa cuando hay síntomas de hiperT4, pero lo más importante son los AINEs.

PREGUNTA 3 Respuesta: A

1.03.1.011 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Síndrome climatérico" (1.03.1.011), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 4 Respuesta: A

1.03.1.017 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Síndrome de secreción inapropiada de ADH" (1.03.1.017), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 5 Respuesta: C

1.05.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo

El cuadro corresponde al Síndrome del Eutiroideo Enfermo (o síndrome de T3 baja), una alteración funcional fisiológica frecuente en pacientes críticos debida al bloqueo de la 5'-desyodasa tisular inducido por citoquinas inflamatorias y cortisol. La administración de levotiroxina o T3 no solo no ha demostrado beneficio en la sobrevida sino que puede incrementar el catabolismo y la mortalidad. La conducta estándar es mantener una actitud expectante y reevaluar las pruebas tiroideas una vez superada la patología crítica de base.

PREGUNTA 6 Respuesta: B

1.05.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo

La definición diagnóstica bioquímica de Hipotiroidismo Subclínico exige la concurrencia de una concentración plasmática de TSH por encima del límite superior normal (típicamente > 4.5 mIU/L, en este caso 7.4 mIU/L) con una concentración sérica de Tiroxina Libre (T4L) que se mantiene estrictamente dentro de los rangos de referencia normales (1.2 ng/dL).

PREGUNTA 7 **Respuesta: D**

1.05.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Hipotiroidismo Primario y Subclínico: Diagnóstico y Titulación de Levotiroxina

En pacientes adultos mayores (> 60 años) o con antecedentes de cardiopatía coronaria (infarto agudo de miocardio previo), el inicio de la terapia sustitutiva con levotiroxina debe ser cauteloso ("start low, go slow"). Iniciar la dosis completa sustitutiva (1.6 mcg/kg/d) puede desencadenar un aumento brusco del consumo miocárdico de oxígeno, precipitando crisis de angina, infarto agudo o arritmias ventriculares graves. La conducta recomendada es iniciar con 25 a 50 mcg/día (o incluso 12.5-25 mcg en coronarios inestables) e incrementar progresivamente en 12.5-25 mcg cada 6 a 8 semanas según el nivel de TSH.

PREGUNTA 8 **Respuesta: B**

1.05.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Hipotiroidismo Primario y Subclínico: Diagnóstico y Titulación de Levotiroxina

La paciente presenta un hipotiroidismo subclínico (TSH entre 4.5 y 9.9 con T4L normal) con dos factores de indicación formal indiscutida para iniciar levotiroxina: 1) Deseo inminente de embarazo (donde la meta preconcepcional y del primer trimestre es TSH < 2.5 mIU/L para optimizar la fertilidad y prevenir pérdidas reproductivas y daño en el neurodesarrollo fetal); y 2) Presencia de anticuerpos Anti-TPO positivos a títulos altos, lo que confiere un alto riesgo de progresión rápida a falla clínica durante la gestación. La indicación es iniciar levotiroxina 25 a 50 mcg/día.

PREGUNTA 9 **Respuesta: C**

1.05.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Hipotiroidismo Primario y Subclínico: Diagnóstico y Titulación de Levotiroxina

La tiroxina (T4) tiene una vida media plasmática prolongada de aproximadamente 7 días. Por consiguiente, se requieren al menos 5 a 6 vidas medias (unas 4 a 6 semanas) para alcanzar un nuevo estado de equilibrio plasmático estacionario y un tiempo adicional para que el eje hipofisario reajuste plenamente la secreción de TSH. Las guías clínicas universales establecen que el control de TSH debe solicitarse a las 6 a 8 semanas tras el inicio o cambio de dosis de levotiroxina.

PREGUNTA 10 **Respuesta: B**

1.05.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Hipotiroidismo Primario y Subclínico: Diagnóstico y Titulación de Levotiroxina

La levotiroxina requiere un pH gástrico ácido y un medio libre de alimentos para su adecuada absorción en el intestino delgado. El consumo concomitante con alimentos, café con leche, suplementos de calcio y sales de hierro quelan el fármaco en el lumen intestinal y disminuyen su biodisponibilidad hasta en un 50–70%, provocando una aparente resistencia al tratamiento. La indicación correcta es instruir la ingesta de levotiroxina en ayuno estricto con agua pura al menos 30 a 60 minutos antes del desayuno, y distanciar el calcio y el hierro por al menos 4 horas.

PREGUNTA 11 **Respuesta: D**

1.03.2.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas

Tiene un coma mixedematoso, en contexto de una GroidiGs autoinmune (reforzada por el viVligo y la anemia perniciosa, que son autoinmunes). La primera medida es dar corticoides EV, seguidos de la levoGroxina EV. Si se da directamente la levoGroxina existe riesgo de producir una insuficiencia suprarrenal aguda.

PREGUNTA 12 **Respuesta: B**

1.05.2.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas

En el tratamiento del coma mixedematoso es una regla de seguridad biológica primordial administrar hidrocortisona endovenosa (100 mg en bolo seguido de 100 mg cada 8 horas) antes o junto con la administración de levotiroxina. La administración aislada de hormona tiroidea incrementa súbitamente el aclaramiento metabólico hepático del cortisol circulante, lo que en pacientes con reserva adrenal agotada desencadenará una crisis suprarrenal aguda fulminante con shock irreversible y muerte.

PREGUNTA 13 **Respuesta: C**

Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas

1.05.2.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

En el coma mixedematoso el recalentamiento debe ser estrictamente pasivo mediante el uso de frazadas o mantas convencionales en una sala climatizada. El recalentamiento activo externo rápido (como baños calientes o mantas térmicas potentes) está formalmente contraindicado porque provoca una vasodilatación periférica brusca e incontrolable que secuestra el volumen sanguíneo en el lecho cutáneo, precipitando un colapso cardiovascular profundo, shock distributivo y muerte por isquemia coronaria.

PREGUNTA 14 **Respuesta: B**

Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas

1.05.2.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El hipotiroidismo severo reduce la tasa de filtración glomerular y la entrega de agua al túbulo distal, estimulando al mismo tiempo la secreción no osmótica de vasopresina (ADH). Esto conduce a una retención severa de agua libre que se traduce clínicamente en una hiponatremia dilucional significativa (frecuentemente < 125 mEq/L). Además, la menor gluconeogénesis y la probable coexistencia de insuficiencia adrenal condicionan una tendencia marcada a la hipoglicemia.

PREGUNTA 15 **Respuesta: B**

Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas

1.05.2.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Las hormonas tiroideas modulan directamente la expresión de las cadenas pesadas de miosina (alfa-MHC) y la recaptación de calcio en el retículo sarcoplásmico por la bomba SERCA2a en los miocitos cardíacos. Su carencia crítica en el coma mixedematoso produce una severa disfunción inotrópica y cronotrópica negativa con bajo gasto cardíaco refractario al aporte de volumen, requiriendo el inicio de soporte inotrópico y vasopresor mientras la levotiroxina ejerce su efecto genómico.

PREGUNTA 16 **Respuesta: C**

Hipotiroidismo en Situaciones Especiales: Embarazo y Tamizaje Neonatal Congénito

1.05.1.005, 4.01.1.013 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Al confirmarse el embarazo, los requerimientos maternos de tiroxina aumentan precozmente entre un 20% y un 50% debido a la elevación de la TBG por hiperestrogenismo, la transferencia transplacentaria de T4 al feto y la degradación placentaria de hormonas tiroideas. Las guías internacionales y del MINSAL recomiendan enfáticamente instruir a las pacientes hipotiroideas a incrementar su dosis en dos comprimidos semanales (aumento del 25-30%) de manera inmediata al confirmar el embarazo, realizando un control de TSH cada 4 semanas para ajustar la dosis.

PREGUNTA 17 **Respuesta: C**

Hipotiroidismo en Situaciones Especiales: Embarazo y Tamizaje Neonatal Congénito

1.05.1.005, 4.01.1.013 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Inmediatamente después del nacimiento se produce una elevación fisiológica súbita y marcada de TSH en el recién nacido ("pico neonatal de TSH") inducida por el enfriamiento térmico extrauterino, la cual desciende gradualmente en las primeras 24 a 36 horas. Para evitar una tasa inaceptable de falsos positivos, la norma técnica del Programa Nacional de Tamizaje Neonatal de Chile (Garantía GES) establece que la muestra de sangre de talón debe recolectarse entre las 40 y 48 horas de vida (o idealmente entre el 2° y 3° día, antes del alta hospitalaria).

PREGUNTA 18 **Respuesta: C**

Tiroiditis: Hashimoto, De Quervain (Subaguda), Silente y Fármacos (Amiodarona, Litio)

1.03.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Hipercalcemia sintomática/severa (Ca >12 mg/dL con síntomas): tratamiento de urgencia = hidratación EV agresiva con SF 0.9% (200-300 mL/h) para promover calciuria. Luego agregar bifosfonatos (zoledronato) o calcitonina. La cintigrafía es para planificación quirúrgica electiva, no urgente.

PREGUNTA 19 **Respuesta: A** Hipertiroidismo 1.03.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Hipertiroidismo + exoftalmo (oftalmopatía de Graves) + bocio difuso en mujer joven = enfermedad de Graves-Basedow (autoinmune, anticuerpos anti-TSH-R). El exoftalmo es patognomónico.

PREGUNTA 20 **Respuesta: A**

Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos

1.03.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Bocio" (1.03.1.001), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 21 **Respuesta: A**

Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos

1.03.1.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Cáncer del tiroides" (1.03.1.004), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 22

Respuesta: B

Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos

1.04.1.002 Dx: TSH suprimida (< 0.01 mIU/L), T4L/T3 elevadas, TRAb positivos (> 1.75 UI/L) y ecografía doppler con infierno tiroideo · Tx: Tiamazol 10-30 mg/día (o PTU en 1er trimestre), betabloqueo sintomático (propranolol/atenolol), radioyodo I-131 o tiroidectomía · Seg: Control T4L/T3 a las 4-6 semanas (la TSH puede permanecer suprimida meses). Monitoreo estricto de neutrófilos si fiebre o dolor faríngeo GES

La presencia de fiebre y odinofagia en un paciente bajo tratamiento con tionamidas (tiamazol o propiltiouracilo) constituye una sospecha ineludible de agranulocitosis medicamentosa (neutrófilos absolutos < 500/uL), complicación inmunológica potencialmente letal. La regla diagnóstica y terapéutica estricta es suspender inmediatamente el fármaco antitiroideo, solicitar un hemograma de urgencia con recuento absoluto de neutrófilos e iniciar aislamiento protector y estudio infeccioso. Si se confirma neutropenia severa, se hospitaliza, se administran antibióticos endovenosos de amplio espectro y factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF). Nunca debe sustituirse por PTU debido a reactividad cruzada de hasta un 50%.

PREGUNTA 23

Respuesta: B

Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos

1.04.1.002 Dx: TSH suprimida (< 0.01 mIU/L), T4L/T3 elevadas, TRAb positivos (> 1.75 UI/L) y ecografía doppler con infierno tiroideo · Tx: Tiamazol 10-30 mg/día (o PTU en 1er trimestre), betabloqueo sintomático (propranolol/atenolol), radioyodo I-131 o tiroidectomía · Seg: Control T4L/T3 a las 4-6 semanas (la TSH puede permanecer suprimida meses). Monitoreo estricto de neutrófilos si fiebre o dolor faríngeo GES

El tiamazol está formalmente contraindicado durante el primer trimestre de la gestación (semanas 1 a 12) debido a su potencial teratogénico, asociándose a la embriopatía por tiamazol (aplasia cutis congénita, atresia de coanas y atresia esofágica). Por esta razón, en toda mujer con hipertiroidismo por Graves que inicia un embarazo, el fármaco de elección obligatorio durante el primer trimestre es el Propiltiouracilo (PTU). Posteriormente, a partir de la semana 13-16 (segundo y tercer trimestre), suele rotarse nuevamente a tiamazol para minimizar el riesgo materno de hepatitis tóxica fulminante inducida por PTU.

PREGUNTA 24

Respuesta: C

Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos

1.04.1.002

Dx: TSH suprimida (< 0.01 mIU/L), T4L/T3 elevadas, TRAb positivos (> 1.75 UI/L) y ecografía doppler con infierno tiroideo · Tx: Tiamazol 10-30 mg/día (o PTU en 1er trimestre), betabloqueo sintomático (propranolol/atenolol), radioyodo I-131 o tiroidectomía · Seg: Control T4L/T3 a las 4-6 semanas (la TSH puede permanecer suprimida meses). Monitoreo estricto de neutrófilos si fiebre o dolor faríngeo

GES

El cuadro clínico y cintigráfico es clásico de un Adenoma Tóxico Autónomo (enfermedad de Plummer unilocular). Se caracteriza por la presencia de un nódulo hipercaptante ('caliente') que produce hormonas tiroideas de manera autónoma e independiente de la regulación por TSH. La hiperproducción hormonal suprime la secreción hipofisaria de TSH, lo que conduce a la inactivación y abolición funcional de la captación en el resto de la glándula tiroidea normal. Es más prevalente en adultos mayores, no se acompaña de oftalmopatía ni mixedema, los TRAb son negativos y con frecuencia debuta con fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca descompensada.

PREGUNTA 25

Respuesta: B

Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos

1.04.1.002

Dx: TSH suprimida (< 0.01 mIU/L), T4L/T3 elevadas, TRAb positivos (> 1.75 UI/L) y ecografía doppler con infierno tiroideo · Tx: Tiamazol 10-30 mg/día (o PTU en 1er trimestre), betabloqueo sintomático (propranolol/atenolol), radioyodo I-131 o tiroidectomía · Seg: Control T4L/T3 a las 4-6 semanas (la TSH puede permanecer suprimida meses). Monitoreo estricto de neutrófilos si fiebre o dolor faríngeo

GES

En pacientes con Enfermedad de Graves y orbitopatía distiroidea moderada a severa activa, el radioyodo I-131 como monoterapia está desaconsejado o formalmente contraindicado relativo, ya que la liberación masiva de antígenos tiroideos provocada por la radiación exacerba marcadamente la inflamación autoinmune retroocular y puede amenazar la visión. En este contexto, la cirugía ablativa (tiroidectomía total) realizada por un equipo experto tras alcanzar eutiroidismo con tionamidas y Lugol es la opción de elección. Si por algún motivo se optara por I-131, es imperativo asociar profilaxis sistémica con glucocorticoides orales (prednisona 0.4-0.5 mg/kg/día iniciada el mismo día del I-131 y mantenida durante 6 semanas con desescalamiento paulatino).

PREGUNTA 26

Respuesta: B

Manejo Terapéutico Comparado: Fármacos, Radioyodo y Cirugía

1.04.1.002

Dx: Evaluación de etiología tiroidea, severidad clínica, comorbilidades cardiovasculares, deseo gestacional y orbitopatía activa · Tx: Tiamazol (1ra línea médica), Radioyodo I-131 (elección en recidivas/BMNT), Tiroidectomía total (bocios gigantes, compresión o sospecha CA) · Seg: Perfil tiroideo a las 4-6 semanas de inicio médico; seguimiento anual con TSH tras I-131 o cirugía por desarrollo inexorable de hipotiroidismo

GES

El radioyodo I-131 destruye el tejido tiroideo hiperfuncionante mediante radiación beta local. En el seguimiento a mediano y largo plazo, la gran mayoría de los pacientes tratados (> 80%) desarrollan hipotiroidismo definitivo, lo cual no se considera un fracaso del tratamiento sino la consecuencia biológica esperada del proceso ablativo curativo. Por esta razón, se les debe advertir formalmente que requerirán controles periódicos de TSH y suplementación diaria indefinida con levotiroxina oral. La lactancia es una contraindicación absoluta para el radioyodo.

PREGUNTA 27

Respuesta: A

Manejo Terapéutico Comparado: Fármacos, Radioyodo y Cirugía

1.04.1.002

Dx: Evaluación de etiología tiroidea, severidad clínica, comorbilidades cardiovasculares, deseo gestacional y orbitopatía activa · Tx: Tiamazol (1ra línea médica), Radioyodo I-131 (elección en recidivas/BMNT), Tiroidectomía total (bocios gigantes, compresión o sospecha CA) · Seg: Perfil tiroideo a las 4-6 semanas de inicio médico; seguimiento anual con TSH tras I-131 o cirugía por desarrollo inexorable de hipotiroidismo

GES

La administración de solución de Lugol (o SSKI, solución saturada de yoduro de potasio) durante 7 a 10 días inmediatamente previos a la cirugía es la práctica estándar en la preparación preoperatoria de la tiroidectomía en pacientes con hipertiroidismo. Las altas concentraciones de yoduro inorgánico desencadenan el efecto Wolff-Chaikoff transitorio (inhibiendo la proteólisis del coloide y la liberación hormonal) y producen una marcada vasoconstricción y disminución del flujo sanguíneo glandular, lo que reduce ostensiblemente el tamaño de los vasos tiroideos, la fragilidad tisular y el riesgo de hemorragia intraoperatoria masiva.

PREGUNTA 28 **Respuesta: A**

Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas

1.03.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Tormenta tiroidea" como urgencia clínica (1.03.2.001), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 29

Respuesta: B

Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas

1.04.1.002 Dx: Clínico urgente mediante Escala de Burch-Wartofsky (≥ 45 puntos = Tormenta Tiroidea altamente probable) · Tx: Abordaje multimodal simultáneo: Bloqueo adrenérgico (Propranolol EV/oral) + PTU alta dosis + Yodo inorgánico (1 h post-PTU) + Hidrocortisona EV · Seg: Monitorización continua en UCI/UTI, hemodinamia invasiva, control electrolítico y detección de infecciones desencadenantes GES

El tratamiento de la tormenta tiroidea debe ser multimodal e instaurado sin demora: 1) Betabloqueo enérgico (propranolol) para controlar la toxicidad adrenérgica; 2) Propiltiouracilo (PTU) para inhibir la síntesis hormonal folicular y bloquear la conversión periférica de T4 a T3; 3) Hidrocortisona endovenosa para compensar la insuficiencia suprarrenal relativa; y 4) Solución de Lugol o SSKI para bloquear la liberación de hormonas preformadas mediante el efecto Wolff-Chaikoff. Es una regla de seguridad estricta diferir el yoduro inorgánico al menos una hora después del PTU para evitar que la glándula lo utilice como sustrato para sintetizar más hormonas (efecto Jod-Basedow). Los salicilatos están contraindicados.

PREGUNTA 30

Respuesta: C

Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas

1.04.1.002 Dx: Clínico urgente mediante Escala de Burch-Wartofsky (≥ 45 puntos = Tormenta Tiroidea altamente probable) · Tx: Abordaje multimodal simultáneo: Bloqueo adrenérgico (Propranolol EV/oral) + PTU alta dosis + Yodo inorgánico (1 h post-PTU) + Hidrocortisona EV · Seg: Monitorización continua en UCI/UTI, hemodinamia invasiva, control electrolítico y detección de infecciones desencadenantes GES

El ácido acetilsalicílico (aspirina) y otros salicilatos están absolutamente contraindicados en el contexto de tirotoxicosis y tormenta tiroidea. Los salicilatos compiten con gran afinidad por los sitios de unión de la globulina fijadora de tiroxina (TBG) y la transtiretina, desplazando a la tiroxina (T4) y triyodotironina (T3) de su unión proteica y disparando de forma brusca las concentraciones séricas de T4 y T3 libres biológicamente activas. Esto intensifica la tormenta tiroidea y precipita colapso cardiovascular. El antipirético de elección es el Paracetamol junto a medios físicos.

PREGUNTA 31

Respuesta: A

Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas

1.04.1.002 Dx: Clínico urgente mediante Escala de Burch-Wartofsky (≥ 45 puntos = Tormenta Tiroidea altamente probable) · Tx: Abordaje multimodal simultáneo: Bloqueo adrenérgico (Propranolol EV/oral) + PTU alta dosis + Yodo inorgánico (1 h post-PTU) + Hidrocortisona EV · Seg: Monitorización continua en UCI/UTI, hemodinamia invasiva, control electrolítico y detección de infecciones desencadenantes GES

En el estado de hipermetabolismo extremo que caracteriza a la tormenta tiroidea, la degradación y el clearance hepático de cortisol están fuertemente acelerados, superando la capacidad de reserva de la corteza suprarrenal para sintetizar glucocorticoides ('insuficiencia suprarrenal relativa'). La administración de hidrocortisona EV a dosis de estrés (100 mg cada 8 horas) es vital para prevenir el colapso hemodinámico letal secundario a hipocortisolismo, al mismo tiempo que ejerce un efecto sinérgico inhibitorio sobre la enzima 5'-desyodasa, bloqueando la conversión periférica de T4 a T3.

PREGUNTA 32

Respuesta: B

Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas

1.04.1.002 Dx: Clínico urgente mediante Escala de Burch-Wartofsky (≥ 45 puntos = Tormenta Tiroidea altamente probable) · Tx: Abordaje multimodal simultáneo: Bloqueo adrenérgico (Propranolol EV/oral) + PTU alta dosis + Yodo inorgánico (1 h post-PTU) + Hidrocortisona EV · Seg: Monitorización continua en UCI/UTI, hemodinamia invasiva, control electrolítico y detección de infecciones desencadenantes GES

La glándula tiroidea hiperactiva en una tormenta capta ávidamente cualquier molécula de yoduro presente en circulación. Si se administra yoduro inorgánico (solución de Lugol o SSKI) antes de haber bloqueado la peroxidasa tiroidea con una tionamida (propiltiouracilo), el exceso masivo de yodo sirve de sustrato directo para la organificación y síntesis de grandes cantidades adicionales de T4 y T3 (efecto Jod-Basedow), lo que agrava de forma letal la tirotoxicosis. Por ello, el PTU debe administrarse primero y esperar al menos una hora para que bloquee la maquinaria enzimática antes de ingresar el yodo que provocará el efecto Wolff-Chaikoff (inhibición de la liberación).

PREGUNTA 33 **Respuesta: A**

Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF

1.03.1.021 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Pregunta difícil, ya que el manejo general del nódulo tiroideo es 1. solicitar TSH (y T4 libre), 2. solicitar ecografía tiroidea (puede ser simultáneamente con la TSH), 3. si tiene más de 10 mm, solicitar PAAF. Sin embargo, la excepción es cuando está hipertiroideo, en que se debe pedir una cintigrafía tiroidea: como en este caso que la TSH está baja y, por tanto, tiene un hipertiroidismo subclínico (con T4 normal). Si es un nódulo caliente (hipercaptante), se diagnostica el adenoma tóxico y se debe extirpar. Si es frío (capta igual o menos que el resto de la tiroides), se procede a la punción.

PREGUNTA 34

Respuesta: B

Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF

1.04.1.003 Dx: TSH sérica + Ecografía tiroidea de alta resolución estandarizada con sistema ACR TI-RADS o ATA · Tx: Según resultado citológico Bethesda: Bethesda II (seguimiento ecográfico), Bethesda V/VI (cirugía oncológica), nódulos calientes (I-131/Cx) · Seg: Control ecográfico a los 6-12 meses según categoría de riesgo ecográfico y estabilidad dimensional GES

En un paciente eutiroideo con un nódulo tiroideo que presenta características ecográficas de alta sospecha de malignidad (ACR TI-RADS 5: sólido, hipoecogénico, márgenes irregulares y microcalcificaciones) y cuyo diámetro mayor supera el umbral estandarizado de 1.0 cm (mide 1.8 cm), la conducta mandataria e inmediata es la realización de una Punción Aspirativa con Aguja Fina (PAAF) guiada por ecografía para categorización citológica según el sistema Bethesda. El cintigrama solo se solicita si la TSH estuviera suprimida, la terapia supresiva con levotiroxina está formalmente en desuso por ineficaz y riesgosa, y la observación diferiría el diagnóstico oncológico.

PREGUNTA 35

Respuesta: C

Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF

1.04.1.003 Dx: TSH sérica + Ecografía tiroidea de alta resolución estandarizada con sistema ACR TI-RADS o ATA · Tx: Según resultado citológico Bethesda: Bethesda II (seguimiento ecográfico), Bethesda V/VI (cirugía oncológica), nódulos calientes (I-131/Cx) · Seg: Control ecográfico a los 6-12 meses según categoría de riesgo ecográfico y estabilidad dimensional GES

En el algoritmo diagnóstico del nódulo tiroideo, si la TSH se encuentra suprimida (< 0.4 mIU/L), el siguiente examen mandatorio es el Cintigrama Tiroideo (gammagrafía). Su objetivo es demostrar si el nódulo es hipercaptante ('caliente') o no captante ('frío'). Los nódulos calientes corresponden a adenomas tóxicos o nódulos autónomos, los cuales poseen un riesgo de malignidad prácticamente nulo (< 1%) y por norma internacional NO deben ser sometidos a PAAF, pasando directamente a tratamiento del hipertiroidismo.

PREGUNTA 36

Respuesta: B

Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF

1.04.1.003 Dx: TSH sérica + Ecografía tiroidea de alta resolución estandarizada con sistema ACR TI-RADS o ATA · Tx: Según resultado citológico Bethesda: Bethesda II (seguimiento ecográfico), Bethesda V/VI (cirugía oncológica), nódulos calientes (I-131/Cx) · Seg: Control ecográfico a los 6-12 meses según categoría de riesgo ecográfico y estabilidad dimensional GES

La categoría Bethesda IV (neoplasia folicular o sospecha de neoplasia folicular) confiere un riesgo de malignidad intrínseco del 25 al 40%. La citología obtenida por PAAF solo permite visualizar la morfología celular folicular, pero es completamente incapaz de distinguir entre un Adenoma Folicular (benigno) y un Carcinoma Folicular (maligno), distinción que depende exclusivamente de demostrar invasión transcapsular o angioinvasión vascular en cortes histológicos de la pieza resecada en su totalidad. Por consiguiente, la conducta quirúrgica estándar es la Hemitiroidectomía (lobectomía tiroidea con istmectomía) para examen diferido. Solo si la biopsia definitiva confirma carcinoma invasor se programa la tiroidectomía total complementaria.

BLOQUE 3 · BLOQUE 3 · CORTEZA Y MÉDULA SUPRARRENAL: CUSHING, ADDISON, CONN Y FEOCROMOCITOMA · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 37 **Respuesta: E** **Hirsutismo**

1.03.1.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

[Pregunta disputada] No se entiende qué es lo que se quería pregunta. La 17-OH progesterona permite diagnosticar la hiperplasia suprarrenal congénita, que es el diagnóstico diferencial del SOP más importante y que también tiene mucho hirsutismo. Por otro lado, la relación LH/FSH elevada sugiere un SOP, aunque no se usa como criterio, por tener muchos falsos negativos.

PREGUNTA 38 **Respuesta: D**

Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico

1.03.1.006 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

El síndrome de Cushing se estudia de elección con el cortisol libre urinario de 24 horas.

PREGUNTA 39 **Respuesta: A**

Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico

1.03.1.022 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Incidentaloma suprarrenal" (1.03.1.022), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 40

Respuesta: B

Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico

1.04.1.005 Dx: Demostrar hipercortisolismo con 2 pruebas de 1ra línea alteradas (CLU 24h, Nugent 1 mg, Cortisol salival nocturno) + ACTH plasmática · Tx: Según etiología: Resección transesfenoidal (Enfermedad de Cushing), Suprarrenalectomía laparoscópica (Adenoma), ketoconazol/metirapona · Seg: Monitoreo de cortisol post-quirúrgico y reemplazo temporal con hidrocortisona por insuficiencia suprarrenal secundaria a atrofia del eje GES

En el algoritmo diagnóstico del Síndrome de Cushing, una vez confirmado el hipercortisolismo bioquímico mediante dos pruebas de primera línea positivas concordantes (en este caso Nugent y CLU de 24 horas), el paso siguiente e inexcusable consiste en determinar si el cuadro es ACTH-dependiente o ACTH-independiente mediante la medición de ACTH plasmática en sangre. Si la ACTH resulta suprimida (< 5-10 pg/mL), el estudio de imágenes se dirigirá a las glándulas suprarrenales (TC abdominal); si resulta normal-alta o francamente elevada (> 15-20 pg/mL), el estudio se dirigirá a la hipófisis (RM de silla turca) o a la búsqueda de foco ectópico.

PREGUNTA 41

Respuesta: C

Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico

1.04.1.005 Dx: Demostrar hipercortisolismo con 2 pruebas de 1ra línea alteradas (CLU 24h, Nugent 1 mg, Cortisol salival nocturno) + ACTH plasmática · Tx: Según etiología: Resección transesfenoidal (Enfermedad de Cushing), Suprarrenalectomía laparoscópica (Adenoma), ketoconazol/metirapona · Seg: Monitoreo de cortisol post-quirúrgico y reemplazo temporal con hidrocortisona por insuficiencia suprarrenal secundaria a atrofia del eje GES

El cuadro clínico corresponde al Síndrome de Cushing Ectópico, clásicamente asociado a Carcinoma Pulmonar Microcítico o tumores neuroendocrinos/carcinoides. A diferencia de la Enfermedad de Cushing hipofisaria habitual, los tumores neuroendocrinos malignos producen concentraciones masivas de ACTH y precursores (POMC) de instauración rápida, lo que impide el desarrollo del fenotipo cushingoide típico (obesidad centrípeta) pero desencadena una severa hipokalemia con alcalosis metabólica (por activación cruzada masiva del receptor mineralocorticoide por el cortisol libre) e hiperpigmentación cutánea (por estimulación de receptores de melanocortina 1). La ausencia de supresión con 8 mg de dexametasona confirma la completa autonomía de la producción tumoral ectópica.

PREGUNTA 42

Respuesta: B

Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico

1.04.1.005 Dx: Demostrar hipercortisolismo con 2 pruebas de 1ra línea alteradas (CLU 24h, Nugent 1 mg, Cortisol salival nocturno) + ACTH plasmática · Tx: Según etiología: Resección transesfenoidal (Enfermedad de Cushing), Suprarrenalectomía laparoscópica (Adenoma), ketoconazol/metirapona · Seg: Monitoreo de cortisol post-quirúrgico y reemplazo temporal con hidrocortisona por insuficiencia suprarrenal secundaria a atrofia del eje GES

En el Síndrome de Cushing por adenoma suprarrenal unilateral autónomo, los niveles suprafisiológicos crónicos de cortisol suprimen de forma prolongada la síntesis y secreción de CRH hipotalámica y ACTH hipofisaria, lo que induce una atrofia estructural y funcional severa de la corteza suprarrenal contralateral. Al extirpar quirúrgicamente el adenoma hipersecretor, el paciente pasa bruscamente de un estado de hipercortisolismo a una insuficiencia suprarrenal secundaria aguda potencialmente mortal (colapso circulatorio hemodinámico). Por ello, es mandatorio iniciar terapia sustitutiva con Hidrocortisona inmediatamente en el postoperatorio y mantenerla durante varios meses (generalmente 6 a 12 meses) hasta que el eje recupere su reactividad normal.

PREGUNTA 43

Respuesta: B

Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico

1.04.1.005

Dx: Demostrar hipercortisolismo con 2 pruebas de 1ra línea alteradas (CLU 24h, Nugent 1 mg, Cortisol salival nocturno) + ACTH plasmática · Tx: Según etiología: Resección transesfenoidal (Enfermedad de Cushing), Suprarrenalectomía laparoscópica (Adenoma), ketoconazol/metirapona · Seg: Monitoreo de cortisol post-quirúrgico y reemplazo temporal con hidrocortisona por insuficiencia suprarrenal secundaria a atrofia del eje

GES

Las tres pruebas de primera línea validadas internacionalmente y con mayor sensibilidad y especificidad diagnóstica para demostrar hipercortisolismo patológico son: 1) Test de supresión con dexametasona 1 mg a las 23 h (Test de Nugent), considerando normal un cortisol plasmático < 1.8 mcg/dL a las 08 h; 2) Cortisol Libre Urinario (CLU) en orina de 24 horas; y 3) Cortisol salival nocturno (a las 23:00 h). El cortisol plasmático matinal aislado de las 08:00 h no tiene utilidad diagnóstica alguna debido a que se encuentra dentro del rango normal en la mayoría de los pacientes con Cushing, fallando en evaluar la pérdida del ritmo circadiano y la falta de autorregulación.

PREGUNTA 44 **Respuesta: C**

Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria

1.03.1.007

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

Es una insuficiencia suprarrenal por TBC. Es la segunda causa de Addison, después de la causa autoinmune. En FB alguien puso K: 2,9 y en ese caso sería un síndrome de secreción ectópica de ACTH, que tiene una clínica totalmente distinta y que es un síndrome paraneoplásico.

PREGUNTA 45 **Respuesta: A**

Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria

1.03.1.019

Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Osteoporosis secundaria" (1.03.1.019), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Completo y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 46 **Respuesta: D**

Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria

1.03.2.003

Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar

GES

Tiene una crisis suprarrenal clásica: shock refractario, hiponatremia, hipoglicemia e hiperkalemia (el K+ está normal en este caso, pero en el límite alto). Sin embargo, también tiene una insuficiencia renal aguda (creatinina elevada), pero el diagnóstico más importante es la insuficiencia suprarrenal.

PREGUNTA 47

Respuesta: C

Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria

1.04.1.006

Dx: Cortisol plasmático matinal (< 3 mcg/dL confirma; 3-15 requiere test de ACTH/Synacthen). ACTH elevada confirma primaria (Addison); ACTH baja orienta a secundaria · Tx: Reemplazo con Hidrocortisona (15-25 mg/día en 2-3 tomas) + Fludrocortisona (0.05-0.1 mg/día SOLO en primaria/Addison). Educar ajuste por estrés · Seg: Monitoreo clínico (peso, PA de pie/sentado, energía), electrolitos plasmáticos y renina plasmática. NUNCA guiar dosis con cortisol plasmático

GES

El paciente presenta una Insuficiencia Suprarrenal Primaria (Enfermedad de Addison), confirmada por el cortisol < 3 mcg/dL, ACTH marcadamente elevada, hiperpigmentación cutáneo-mucosa y el trastorno hidroelectrolítico con hiponatremia e hiperkalemia severa secundario a déficit concomitante de mineralocorticoides. Al estar destruida la totalidad de la corteza suprarrenal, el paciente carece tanto de cortisol como de aldosterona. Por lo tanto, el esquema terapéutico sustitutivo crónico indispensable de por vida exige la combinación de un glucocorticoide (Hidrocortisona 15-25 mg/día repartidos) y un mineralocorticoide (Fludrocortisona 0.05-0.1 mg/día en toma matinal única).

PREGUNTA 48

Respuesta: B

Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria

1.04.1.006

Dx: Cortisol plasmático matinal (< 3 mcg/dL confirma; 3-15 requiere test de ACTH/Synacthen). ACTH elevada confirma primaria (Addison); ACTH baja orienta a secundaria · Tx: Reemplazo con Hidrocortisona (15-25 mg/día en 2-3 tomas) + Fludrocortisona (0.05-0.1 mg/día SOLO en primaria/Addison). Educar ajuste por estrés · Seg: Monitoreo clínico (peso, PA de pie/sentado, energía), electrolitos plasmáticos y renina plasmática. NUNCA guiar dosis con cortisol plasmático

GES

La suspensión brusca de una corticoterapia sistémica administrada a dosis suprafisiológicas por más de 3 a 4 semanas es la causa más común de Insuficiencia Suprarrenal Secundaria/Terciaria. El glucocorticoide exógeno inhibe de forma persistente la síntesis de CRH hipotalámica y ACTH hipofisaria (demostrada por la ACTH suprimida de 4 pg/mL), conduciendo a la atrofia por desuso de la zona fascicular y reticular de la corteza suprarrenal. Dado que la zona glomerulosa productora de aldosterona no depende de ACTH sino del sistema renina-angiotensina, la aldosterona se encuentra conservada, razón por la cual los niveles de potasio son rigurosamente normales (K+ 4.2 mEq/L) y no se produce hiperpigmentación.

PREGUNTA 49

Respuesta: C

Crisis Suprarrenal Aguda y Shock Refractario

1.04.1.006

Dx: Sospecha clínica inmediata ante shock hipotensivo refractario a fluidos y aminas vasoactivas en paciente con antecedente adrenal o corticoterapia previa · Tx: Hidrocortisona 100 mg bolo EV inmediato + Reposición agresiva con Suero Fisiológico al 0.9% y Suero Glucosado al 5-10% EV. NUNCA diferir por exámenes · Seg: Hospitalización en UCI/UTI, monitoreo hemodinámico continuo invasivo, corrección de hipoglicemia e hiperkalemia, y búsqueda de foco séptico desencadenante

GES

El paciente presenta una Crisis Suprarrenal Aguda con shock refractario a volumen desencadenado por una sepsis de foco respiratorio. En ausencia de concentraciones adecuadas de cortisol, las arteriolas pierden la reactividad normal a las catecolaminas endógenas y exógenas debido al downregulation funcional de los receptores adrenérgicos vasculares, lo que perpetúa la vasodilatación sistémica letal. La administración inmediata de Hidrocortisona 100 mg en bolo endovenoso restaura el tono vascular, restablece la permeabilidad capilar y permite recuperar la presión arterial. Administrar noradrenalina sin corticoides en este contexto es completamente ineficaz.

PREGUNTA 50

Respuesta: B

Crisis Suprarrenal Aguda y Shock Refractario

1.04.1.006

Dx: Sospecha clínica inmediata ante shock hipotensivo refractario a fluidos y aminas vasoactivas en paciente con antecedente adrenal o corticoterapia previa · Tx: Hidrocortisona 100 mg bolo EV inmediato + Reposición agresiva con Suero Fisiológico al 0.9% y Suero Glucosado al 5-10% EV. NUNCA diferir por exámenes · Seg: Hospitalización en UCI/UTI, monitoreo hemodinámico continuo invasivo, corrección de hipoglicemia e hiperkalemia, y búsqueda de foco séptico desencadenante

GES

El cuadro clínico de colapso hemodinámico a las 2 semanas de vida con crisis de pérdida salina severa (hiponatremia extrema Na+ 118 y severa hiperkalemia K+ 7.8) e hiperpigmentación genital es la presentación clásica y potencialmente fatal de la Hiperplasia Suprarrenal Congénita en su forma clásica perdedora de sal por déficit de la enzima 21-hidroxilasa. La incapacidad para sintetizar cortisol y aldosterona genera una crisis suprarrenal neonatal aguda. El tratamiento urgente e inaplazable consiste en reanimación con suero fisiológico isotónico para expandir la volemia y administración precoz de Hidrocortisona endovenosa.

PREGUNTA 51

Respuesta: B

Crisis Suprarrenal Aguda y Shock Refractario

1.04.1.006

Dx: Sospecha clínica inmediata ante shock hipotensivo refractario a fluidos y aminas vasoactivas en paciente con antecedente adrenal o corticoterapia previa · Tx: Hidrocortisona 100 mg bolo EV inmediato + Reposición agresiva con Suero Fisiológico al 0.9% y Suero Glucosado al 5-10% EV. NUNCA diferir por exámenes · Seg: Hospitalización en UCI/UTI, monitoreo hemodinámico continuo invasivo, corrección de hipoglicemia e hiperkalemia, y búsqueda de foco séptico desencadenante

GES

Una de las reglas de oro de mayor relevancia y evaluación en el examen EUNACOM ante la sospecha fundada de Crisis Suprarrenal Aguda es que el tratamiento de rescate es una URGENCIA VITAL INAPLAZABLE. Bajo ninguna circunstancia se debe retrasar o posponer la administración de la Hidrocortisona endovenosa a la espera de los resultados de laboratorio o pruebas diagnósticas complementarias. La mortalidad de esta condición en ausencia de tratamiento glucocorticoide inmediato es altísima debido a la falla circulatoria refractaria. La conducta estándar es extraer la muestra sanguínea y administrar de inmediato el fármaco.

PREGUNTA 52

Respuesta: B

1.04.1.006

Crisis Suprarrenal Aguda y Shock Refractario

Dx: Sospecha clínica inmediata ante shock hipotensivo refractario a fluidos y aminas vasoactivas en paciente con antecedente adrenal o corticoterapia previa · Tx: Hidrocortisona 100 mg bolo EV inmediato + Reposición agresiva con Suero Fisiológico al 0.9% y Suero Glucosado al 5-10% EV. NUNCA diferir por exámenes · Seg: Hospitalización en UCI/UTI, monitoreo hemodinámico continuo invasivo, corrección de hipoglicemia e hiperkalemia, y búsqueda de foco séptico desencadenante

GES

La molécula de hidrocortisona posee afinidad intrínseca equivalente tanto por el receptor glucocorticoide como por el receptor mineralocorticoide. A dosis de sustitución fisiológica crónica (20 mg/día), la enzima 11beta-HSD2 inactiva el cortisol a cortisona en el riñón, requiriendo el aporte adicional de fludrocortisona en pacientes con Addison. Sin embargo, a dosis de estrés suprafisiológicas utilizadas en la crisis aguda (≥ 100 a 200 mg/día de hidrocortisona), la capacidad enzimática de la 11beta-HSD2 se satura masivamente por completo, permitiendo que el exceso de cortisol active con máxima potencia los receptores mineralocorticoides de los túbulos renales, ejerciendo una acción retenedora de sal y excretora de potasio idéntica a la aldosterona.

PREGUNTA 53

Respuesta: B

Hiperaldosteronismo Primario (Síndrome de Conn) e HTA Secundaria

1.04.1.007

Dx: Relación Aldosterona / Renina Plasmática (RAR > 20-30 con Aldosterona > 15 ng/dL) + Test confirmatorio (sobrecarga salina) + TC Suprarrenal · Tx: Adenoma unilateral (Conn): Suprarrenalectomía laparoscópica unilateral curativa. Hiperplasia bilateral: Antagonistas del receptor mineralocorticoide (Espironolactona) · Seg: Monitorización de presión arterial, kalemia y función renal. Monitoreo de ginecomastia con espironolactona (rotar a Eplerenona si efectos adversos)

GES

El examen de tamizaje de primera línea universalmente recomendado para evaluar la sospecha de Hiperaldosteronismo Primario es la Relación entre la concentración de Aldosterona Plasmática y la Actividad de Renina Plasmática (RAR). En condiciones normales, el eje renina-angiotensina regula a la aldosterona; en el hiperaldosteronismo primario la secreción autónoma de aldosterona expande el volumen extracelular y suprime potentemente la renina, generando una RAR marcadamente elevada (> 20 a 30 con aldosterona > 15 ng/dL). El estudio de imágenes (TC adrenal) solo se solicita tras la confirmación bioquímica de la prueba de tamizaje.

PREGUNTA 54

Respuesta: B

Hiperaldosteronismo Primario (Síndrome de Conn) e HTA Secundaria

1.04.1.007

Dx: Relación Aldosterona / Renina Plasmática (RAR > 20-30 con Aldosterona > 15 ng/dL) + Test confirmatorio (sobrecarga salina) + TC Suprarrenal · Tx: Adenoma unilateral (Conn): Suprarrenalectomía laparoscópica unilateral curativa. Hiperplasia bilateral: Antagonistas del receptor mineralocorticoide (Espironolactona) · Seg: Monitorización de presión arterial, kalemia y función renal. Monitoreo de ginecomastia con espironolactona (rotar a Eplerenona si efectos adversos)

GES

En pacientes con Hiperaldosteronismo Primario debido a Hiperplasia Suprarrenal Bilateral (la causa más frecuente de HAP, representando el 60-65% de los casos), la cirugía resectiva no está indicada debido a que requeriría suprarrenalectomía bilateral con consecuente insuficiencia suprarrenal primaria permanente de por vida. El tratamiento estándar de elección indiscutido es el manejo médico con un antagonista competitivo del receptor mineralocorticoide, siendo la Espironolactona el fármaco de primera línea (a dosis de 25 a 100 mg/día). Este fármaco bloquea la acción de la aldosterona a nivel del túbulo colector, normalizando la presión arterial y reteniendo potasio para revertir la hipokalemia.

BLOQUE 4 · BLOQUE 4 · METABOLISMO MINERAL, CALCIO, PARATIROIDES Y HUESO · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 55 **Respuesta: A** Hipercalcemias e hipocalcemias 1.03.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene hipercalcemia, con elevación de la PTH, así que se confirma el diagnóstico de un hiperparatiroidismo primario. El secundario tiene la calcemia baja o normal y suele ser por IRC. El terciario es igual al primario, pero en un paciente con IRC, que tenía uno secundario y luego empezó a tener hipercalcemia, en lugar de la hipocalcemia del secundario. La hipercalcemia maligna tiene PTH baja. La hipercalciuria primaria sí tiene litiasis, pero la PTH y la calcemia son normales. El hiperparatiroidismo primario tiene hipercalciuria secundaria y, por ello, se produce la litiasis también.

PREGUNTA 56 **Respuesta: B** Hipercalcemias e hipocalcemias 1.03.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Calcio alto y PTH alta son característicos del HPP.

PREGUNTA 57 **Respuesta: A** Hipercalcemias e hipocalcemias 1.03.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

PTH es el primer examen a solicitar en hipercalcemia: PTH elevada = hiperparatiroidismo primario (causa más frecuente en ambulatorio). PTH suprimida = hipercalcemia de malignidad, intoxicación vitamina D u otras causas. Orienta todo el estudio.

PREGUNTA 58 **Respuesta: A** Hipercalcemias e hipocalcemias 1.03.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Hipercalcemia + hipofosforemia + PTH inapropiadamente elevada en paciente asintomático = hiperparatiroidismo primario. Es la causa más frecuente de hipercalcemia en pacientes ambulatorios. PTH suprimida en malignidad.

PREGUNTA 59 **Respuesta: B** Hipercalcemias e hipocalcemias 1.03.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una hipercalcemia, con la posibilidad de ser secundaria al cáncer. Igualmente se estudia con PTH, ya que si está elevada es un hiperparatiroidismo primario y si está baja, es probablemente un cáncer.

PREGUNTA 60 **Respuesta: C** Hipercalcemias e hipocalcemias 1.03.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Aunque tenga imágenes de metástasis, también pueden ser causadas por un hiperparatiroidismo primario (HPP). Por eso es que la hipercalcemia se estudia siempre con PTH: si está elevada es un HPP y si está baja es cáncer. La cintigrafía ósea es una forma de buscar metástasis que no se han visto (en este caso ya las vio la radiografía) y se pide, por ejemplo, en la etapificación del cáncer de próstata con APE mayor a 20; sin embargo, es inespecífica, porque también se altera con otros procesos de hiperactividad ósea (osteoclástica), como el HPP.

PREGUNTA 61 **Respuesta: B** Tetania 1.03.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

Gluconato de calcio endovenoso

PREGUNTA 62

Respuesta: B

Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico

1.04.1.009

Dx: Calcio total corregido por albúmina o Calcio Iónico + PTH intacta (PTHi). PTH elevada/inapropiada = HPT 1°; PTH suprimida = Neoplasia / Vit D · Tx: Crisis aguda: Suero fisiológico 0.9% enérgico + Ácido Zoledrónico EV +/- Calcitonina. HPT 1°: Paratiroidectomía si cumple criterios · Seg: Calcio sérico, fósforo y función renal post-resección. Monitoreo de hipocalcemia severa por 'Síndrome del Hueso Hambriento'

GES

El paciente se encuentra cursando una Crisis Hipercalcémica Severa (calcio corregido ≥ 14 mg/dL) de origen neoplásico (PTH suprimida, secundario a secreción tumoral de PTHrP). Los pacientes con hipercalcemia severa presentan invariablemente una depleción masiva de volumen intravascular (déficit de 3 a 5 litros de agua y electrolitos) debido a la diuresis osmótica nefrogénica inducida por calcio y los vómitos. La medida inicial de máxima prioridad e indiscutible antes de cualquier otra intervención es la restitución enérgica de volumen con Suero Fisiológico al 0.9% (2 a 4 litros en las primeras 24 horas). Esto restaura la perfusión renal e induce calciuresis salina. La furosemida está contraindicada en deshidratación, y el zoledronato requiere expansión de volumen previa.

PREGUNTA 63

Respuesta: A

Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico

1.04.1.009

Dx: Calcio total corregido por albúmina o Calcio Iónico + PTH intacta (PTHi). PTH elevada/inapropiada = HPT 1°; PTH suprimida = Neoplasia / Vit D · Tx: Crisis aguda: Suero fisiológico 0.9% enérgico + Ácido Zoledrónico EV +/- Calcitonina. HPT 1°: Paratiroidectomía si cumple criterios · Seg: Calcio sérico, fósforo y función renal post-resección. Monitoreo de hipocalcemia severa por 'Síndrome del Hueso Hambriento'

GES

Ante el hallazgo confirmado de hipercalcemia, la prueba diagnóstica cardinal para categorizar el mecanismo fisiopatológico es la medición de Hormona Paratiroidea Intacta (PTHi). En condiciones fisiológicas normales, una concentración sérica elevada de calcio suprime por completo la liberación de PTH por las glándulas paratiroides mediante la estimulación del receptor sensor de calcio (CaSR). Si la PTH intacta se encuentra elevada o 'inapropiadamente normal' (no suprimida) en coexistencia con hipercalcemia, se establece formalmente el diagnóstico de Hiperparatiroidismo Primario (o raramente hipercalcemia hipocalciúrica familiar).

PREGUNTA 64

Respuesta: B

Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico

1.04.1.009

Dx: Calcio total corregido por albúmina o Calcio Iónico + PTH intacta (PTHi). PTH elevada/inapropiada = HPT 1°; PTH suprimida = Neoplasia / Vit D · Tx: Crisis aguda: Suero fisiológico 0.9% enérgico + Ácido Zoledrónico EV +/- Calcitonina. HPT 1°: Paratiroidectomía si cumple criterios · Seg: Calcio sérico, fósforo y función renal post-resección. Monitoreo de hipocalcemia severa por 'Síndrome del Hueso Hambriento'

GES

De acuerdo con el consenso de las Guías Internacionales sobre el Manejo del Hiperparatiroidismo Primario Asintomático, la paciente cumple múltiples criterios formales de indicación quirúrgica de Paratiroidectomía: 1) Edad menor de 50 años (tiene 44 años); 2) Calcio sérico > 1.0 mg/dL por encima del límite superior normal (11.8 mg/dL vs límite 10.5); 3) Osteoporosis demostrada por densitometría ósea con T-score < -2.5 (presenta -2.7 en columna lumbar); y 4) Presencia de nefrolitiasis asintomática demostrada por imagen. La paratiroidectomía es el único tratamiento curativo definitivo, el cual normaliza la calcemia y revierte la pérdida de masa ósea.

PREGUNTA 65

Respuesta: A

Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico

1.04.1.009

Dx: Calcio total corregido por albúmina o Calcio Iónico + PTH intacta (PTHi). PTH elevada/inapropiada = HPT 1°; PTH suprimida = Neoplasia / Vit D · Tx: Crisis aguda: Suero fisiológico 0.9% enérgico + Ácido Zoledrónico EV +/- Calcitonina. HPT 1°: Paratiroidectomía si cumple criterios · Seg: Calcio sérico, fósforo y función renal post-resección. Monitoreo de hipocalcemia severa por 'Síndrome del Hueso Hambriento'

GES

El cuadro corresponde al Síndrome del Hueso Hambriento (Hungry Bone Syndrome), una complicación postoperatoria típica tras la paratiroidectomía en pacientes que presentaban hiperparatiroidismo primario de larga data o con compromiso óseo severo previo. Al extirpar bruscamente el adenoma hipersecretor de PTH, cesa de forma súbita la resorción osteoclástica masiva inducida por la PTH, mientras que los osteoblastos previamente estimulados captan con extrema avidez cantidades masivas de calcio y fósforo desde la sangre para remineralizar la matriz ósea desmineralizada. Esto provoca una caída abrupta y profunda tanto del calcio sérico (hipocalcemia sintomática severa) como del fósforo (hipofosfatemia concomitante). Requiere aporte masivo de calcio endovenoso y calcitriol oral a dosis altas.

PREGUNTA 66

Respuesta: B

Hipocalcemia Aguda y Crónica: Diagnóstico y Manejo de Emergencia

1.04.1.010

Dx: Calcio total corregido por albúmina < 8.5 mg/dL o Calcio Iónico < 4.0 mg/dL (1.0 mmol/L) + Signos de irritabilidad neuromuscular (Trousseau / Chvostek) · Tx: Aguda sintomática: Gluconato de Calcio al 10% 1-2 ampollas EV en 10-20 min + infusión continua. Corregir magnesio si hipomagnesemia · Seg: Monitoreo cardíaco continuo (riesgo QT largo y arritmias). Monitoreo de calcemia, magnesemia y producto calcio-fósforo en tratamiento crónico

GES

La paciente presenta una hipocalcemia aguda sintomática severa con signos de tetania e inicio de laringoespasmo (estridor inspiratorio) secundario a hipoparatiroidismo post-tiroidectomía. Esta situación constituye una emergencia médica con riesgo inminente de asfixia por laringoespasmo o arritmias ventriculares letales por QT largo. El tratamiento de rescate inmediato de elección es la administración endovenosa lenta de Gluconato de Calcio al 10% (1 a 2 ampollas diluidas administradas en 10 a 20 minutos bajo monitor continuo de ECG). El calcio oral y la vitamina D son insuficientes y demasiado lentos para controlar una emergencia aguda de estas características.

PREGUNTA 67

Respuesta: A

Hipocalcemia Aguda y Crónica: Diagnóstico y Manejo de Emergencia

1.04.1.010

Dx: Calcio total corregido por albúmina < 8.5 mg/dL o Calcio Iónico < 4.0 mg/dL (1.0 mmol/L) + Signos de irritabilidad neuromuscular (Trousseau / Chvostek) · Tx: Aguda sintomática: Gluconato de Calcio al 10% 1-2 ampollas EV en 10-20 min + infusión continua. Corregir magnesio si hipomagnesemia · Seg: Monitoreo cardíaco continuo (riesgo QT largo y arritmias). Monitoreo de calcemia, magnesemia y producto calcio-fósforo en tratamiento crónico

GES

La hipomagnesemia severa (< 1.0 mg/dL) es una causa clásica de hipocalcemia clínicamente indistinguible de la tetania por hipoparatiroidismo y profundamente refractaria a la administración aislada de calcio endovenoso. El magnesio es un cofactor indispensable tanto para la secreción fisiológica de PTH por las paratiroides como para la respuesta de los órganos diana (hueso y riñón) a la propia PTH. En pacientes con pérdidas gastrointestinales, uso crónico de diuréticos o alcoholismo desnutrido, la coexistencia de hipomagnesemia bloquea el eje del calcio. La administración de Sulfato de Magnesio EV es obligatoria para poder corregir la calcemia.

PREGUNTA 68 **Respuesta: D**

Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento

1.03.1.018 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Tiene osteoporosis (T score menor o igual a -2,5). Se deben iniciar los bifosfonatos. Se mantiene el calcio y la vit D

PREGUNTA 69

Respuesta: B

Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento

1.04.1.011 Dx: Densitometría ósea DEXA: T-score ≤ -2.5 en columna lumbar, cuello femoral o cadera total, O presencia de fractura por fragilidad · Tx: 1ra Línea: Alendronato 70 mg/semana VO (o Ácido Zoledrónico 5 mg/año EV) + Calcio (1000-1200 mg/d) + Vitamina D3 (800-2000 UI/d) · Seg: DEXA de control cada 1-2 años. Evaluar 'vacaciones terapéuticas' con bifosfonatos a los 3-5 años por riesgo de fractura atípica de fémur y osteonecrosis mandibular GES

Una de las reglas cardinales más evaluadas en EUNACOM establece que la presencia de una Fractura por Fragilidad en un adulto mayor ante un traumatismo de bajo impacto (caída de su propia altura) en sitios típicos como cadera o vértebras establece el diagnóstico clínico inequívoco de OSTEOPOROSIS SEVERA / ESTABLECIDA, independientemente de que el valor densitométrico del T-score se encuentre en rango de osteopenia (-1.0 a -2.5). Por consiguiente, la paciente tiene indicación perentoria de iniciar tratamiento farmacológico antiosteoporótico activo de primera línea (bifosfonatos orales o zoledronato endovenoso) junto a calcio y vitamina D para reducir el elevado riesgo de una segunda fractura.

PREGUNTA 70

Respuesta: B

Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento

1.04.1.011 Dx: Densitometría ósea DEXA: T-score ≤ -2.5 en columna lumbar, cuello femoral o cadera total, O presencia de fractura por fragilidad · Tx: 1ra Línea: Alendronato 70 mg/semana VO (o Ácido Zoledrónico 5 mg/año EV) + Calcio (1000-1200 mg/d) + Vitamina D3 (800-2000 UI/d) · Seg: DEXA de control cada 1-2 años. Evaluar 'vacaciones terapéuticas' con bifosfonatos a los 3-5 años por riesgo de fractura atípica de fémur y osteonecrosis mandibular GES

Los bifosfonatos orales (alendronato, risedronato) poseen una biodisponibilidad gastrointestinal extremadamente baja (< 1%) y son sumamente irritantes para el epitelio del esófago si permanecen en contacto prolongado con la mucosa. Para asegurar su absorción y prevenir la esofagitis ulcerativa por decúbito, se instruye a la paciente a: 1) Tomarlo en ayunas con un vaso completo (200 mL) de agua de la llave pura (los alimentos, lácteos, jugos y el calcio quelan el bifosfonato e impiden su absorción); 2) No consumir alimentos ni otros fármacos en los siguientes 30 a 60 minutos; y 3) Permanecer erguida (de pie o sentada) sin acostarse durante al menos 30 a 60 minutos.

PREGUNTA 71

Respuesta: B

Déficit de Vitamina D, Osteomalacia del Adulto y Raquitismo

1.04.1.012 Dx: 25-hidroxivitamina D sérica [25(OH)D]: < 20 ng/mL = Deficiencia; 20-29 ng/mL = Insuficiencia; ≥ 30 ng/mL = Suficiencia óptima · Tx: Deficiencia (< 20 ng/mL): Colecalciferol (D3) 50.000 UI semanal por 8 semanas (o 6.000 UI/día), seguido de mantención 1.000-2.000 UI/día · Seg: Control de 25(OH)D sérica a los 3-4 meses de iniciada la carga de reposición. Monitoreo de calcemia y fosfemia GES

El marcador biológico específico, validado internacionalmente y con mayor precisión diagnóstica para cuantificar los depósitos corporales de vitamina D y diagnosticar tanto su deficiencia como su insuficiencia es la 25-Hidroxivitamina D sérica [25(OH)D o calcidiol]. Posee una vida media plasmática de 2 a 3 semanas y refleja de manera fiel la síntesis cutánea solar y la ingesta dietética. La medición de 1,25-dihidroxivitamina D (calcitriol) es un error conceptual frecuente en la práctica y en el examen EUNACOM, dado que en estados tempranos de deficiencia la PTH se eleva estimulando la 1-alfa-hidroxilasa renal, manteniendo niveles normales o paradójicamente elevados de calcitriol.

PREGUNTA 72

Respuesta: A

Déficit de Vitamina D, Osteomalacia del Adulto y Raquitismo

1.04.1.012

Dx: 25-hidroxivitamina D sérica [25(OH)D]: < 20 ng/mL = Deficiencia; 20-29 ng/mL = Insuficiencia; ≥ 30 ng/mL = Suficiencia óptima · Tx: Deficiencia (< 20 ng/mL): Colecalciferol (D3) 50.000 UI semanal por 8 semanas (o 6.000 UI/día), seguido de mantención 1.000-2.000 UI/día · Seg: Control de 25(OH)D sérica a los 3-4 meses de iniciada la carga de reposición. Monitoreo de calcemia y fosfemia

GES

En pacientes con deficiencia severa de vitamina D (< 20 ng/mL y especialmente < 10 ng/mL) con osteomalacia clínica y bioquímica documentada, el esquema terapéutico estándar de reposición rápida recomendado por las guías endocrinológicas consiste en dosis altas de choque de Colecalciferol (vitamina D3) a razón de 50.000 UI vía oral una vez a la semana durante 8 semanas (o 6.000 UI diarias por 8 semanas). Este esquema repleta los depósitos tisulares saturando los receptores diana, y debe acompañarse obligatoriamente de 1.000 a 1.200 mg/día de calcio elemental. Los fármacos antirresortivos (como bifosfonatos) están FORMALMENTE CONTRAINDICADOS en presencia de osteomalacia activa no corregida porque empeoran la desmineralización ósea.

BLOQUE 5 · BLOQUE 5 · HIPÓFISIS, HIPOTÁLAMO, NEUROENDOCRINOLOGÍA Y MEN · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 73 **Respuesta: D** **Amenorrea**

1.03.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene un hipogonadismo hipogonadotrófico (las gonadotropinas normales se consideran como hipogonadotrófico), por lo que es de causa hipotalámica o hipofisiaria (el hipo- hipo es hipo-hipo).

PREGUNTA 74 **Respuesta: B** **Hipogonadismo masculino**

1.03.1.012 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

Es un hipogonadismo clínico (disminuición del vello corporal, astenia y disfunción sexual: impotencia y disminución del deseo sexual), que se estudia con gonadotropinas (LH) y hormonas sexuales (testosterona en el hombre).

PREGUNTA 75 **Respuesta: A** **Ginecomastia**

1.03.1.023 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Ginecomastia bilateral en adolescente Tanner 3 sin medicamentos ni masa firme = ginecomastia puberal fisiológica. Ocurre en 50-70% de los púberes. Regresa espontáneamente en 1-2 años.

PREGUNTA 76 **Respuesta: D**

Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria

1.03.1.009 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

Es un hiperaldosteronismo clásico. La hipertensión renovascular también puede presentar hipokalemia (porque produce un hiperaldosteronismo secundario, por activación de eje renina – angiotensina – aldosterona), pero el resto de la clínica calza mejor con hiperaldosteronismo primario (mucha debilidad, calambres y cefalea). En cambio, la HTA RV tiene soplo abdominal y algo de elevación de la creatininemia.

PREGUNTA 77 **Respuesta: D**

Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria

1.03.1.013 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

La acromegalia se estudia primero con somatomedina 1 o IGF1 (son sinónimos). La GH es muy errática y no se pide.

PREGUNTA 78

Respuesta: B

Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria

1.04.1.013

Dx: RM de Silla Turca con gadolinio + Campo visual computarizado + Evaluación hormonal completa de todos los ejes hipofisarios · Tx: Compresión quiasmática o tumores no funcionantes grandes: Cirugía transesfenoidal. Apoplejía: Hidrocortisona EV inmediata +/- descompresión urgente · Seg: RM de control anual, campimetría periódica y seguimiento hormonal para pesquisar hipopituitarismo diferido postquirúrgico

GES

En presencia de un Macroadenoma Hipofisario no funcionante (o clínicamente silente) que genera compromiso estructural de la vía visual evidenciado por hemianopsia bitemporal y compresión quiasmática evidente en la RM, la indicación de tratamiento de elección indiscutida es la Cirugía de Resección por vía Transesfenoidal (endoscópica o microquirúrgica). El objetivo primordial de la intervención es la descompresión mecánica urgente del quiasma óptico para permitir la recuperación funcional de los axones visuales y prevenir la atrofia óptica irreversible. Los agonistas dopaminérgicos como la cabergolina son ineficaces para reducir significativamente los adenomas no prolactinomas.

PREGUNTA 79

Respuesta: B

Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria

1.04.1.013

Dx: RM de Silla Turca con gadolinio + Campo visual computarizado + Evaluación hormonal completa de todos los ejes hipofisarios · Tx: Compresión quiasmática o tumores no funcionantes grandes: Cirugía transesfenoidal. Apoplejía: Hidrocortisona EV inmediata +/- descompresión urgente · Seg: RM de control anual, campimetría periódica y seguimiento hormonal para pesquisar hipopituitarismo diferido postquirúrgico

GES

El paciente se encuentra cursando una Apoplejía Hipofisaria aguda hemorrágica con compresión de estructuras quiasmáticas y del seno cavernoso derecho (parálisis del III par). En esta catástrofe neuroendocrina, la necrosis hemorrágica masiva destruye bruscamente el tejido hipofisario remanente, provocando un hipopituitarismo agudo fulminante con colapso de la secreción de ACTH. La consiguiente crisis suprarrenal aguda secundaria es la causa primordial de mortalidad perioperatoria rápida por shock circulatorio refractario (como refleja su hipotensión PA 85/50). Por lo tanto, la medida inicial más urgente y prioritaria antes del traslado a pabellón neuroquirúrgico descompresivo es la administración inmediata de Hidrocortisona 100 mg EV en bolo directo.

PREGUNTA 80 **Respuesta: B**

Hiperprolactinemia y Prolactinomas: Diagnóstico y Terapia Médica

1.03.1.016

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

Tiene una hiperprolactinemia. No tiene la amenorrea clásica, porque usa anticonceptivos.

PREGUNTA 81

Respuesta: B

Hiperprolactinemia y Prolactinomas: Diagnóstico y Terapia Médica

1.04.1.014

Dx: Prolactina sérica basal > 25 ng/mL (en ayuno, sin estrés, reposo 30 min). > 100 ng/mL = Prolactinoma altamente probable; > 200 ng/mL = casi patognomónico · Tx: 1ra Línea ABSOLUTA: Agonistas Dopaminérgicos (Cabergolina 0.5 mg 1-2 veces/semana VO). Cirugía transesfenoidal solo si resistencia/intolerancia · Seg: Prolactina sérica a los 3 meses y RM de silla turca de control al año para evaluar reducción tumoral. Monitoreo de ecocardiograma si dosis altas

GES

El tratamiento de primera línea de elección para los prolactinomas (tanto microadenomas como macroadenomas) es la terapia médica con agonistas dopaminérgicos, siendo la Cabergolina el fármaco de elección indiscutido debido a su alta eficacia, dosificación semanal cómoda y excelente perfil de tolerancia. La cabergolina normaliza los niveles de prolactina en más del 85% de las pacientes, induce una reducción volumétrica tumoral significativa y restaura los ciclos ovulatorios y la fertilidad normal en pocas semanas. La cirugía transesfenoidal queda relegada a casos excepcionales con resistencia demostrada o intolerancia grave a los agonistas.

PREGUNTA 82

Respuesta: B

Hiperprolactinemia y Prolactinomas: Diagnóstico y Terapia Médica

1.04.1.014

Dx: Prolactina sérica basal > 25 ng/mL (en ayuno, sin estrés, reposo 30 min). > 100 ng/mL = Prolactinoma altamente probable; > 200 ng/mL = casi patognomónico · Tx: 1ra Línea ABSOLUTA: Agonistas Dopaminérgicos (Cabergolina 0.5 mg 1-2 veces/semana VO). Cirugía transesfenoidal solo si resistencia/intolerancia · Seg: Prolactina sérica a los 3 meses y RM de silla turca de control al año para evaluar reducción tumoral. Monitoreo de ecocardiograma si dosis altas

GES

La risperidona es un antipsicótico atípico que posee una potentísima actividad antagonista de los receptores dopaminérgicos D2 a nivel del sistema nervioso central y periférico. Al bloquear los receptores D2 en los lactotropos de la adenohipófisis, interrumpe el tono inhibitorio tónico fisiológico que ejerce la dopamina sobre la secreción de prolactina, provocando una hiperprolactinemia farmacológica (habitualmente con niveles entre 30 y 100 ng/mL) que se manifiesta por galactorrea, oligomenorrea o amenorrea e hipoestrogenismo. Es una causa sumamente prevalente en la práctica que no requiere imágenes selares si el cuadro coincide con la introducción o aumento del fármaco.

PREGUNTA 83

Respuesta: B

Acromegalia y Gigantismo: Diagnóstico Bioquímico y Manejo

1.04.1.015

Dx: Tamizaje: IGF-1 sérica elevada para edad y sexo. Confirmación: Test de Sobrecarga Oral de Glucosa (PTGO 75g con GH que no suprime a < 1.0 o 0.4 mcg/L) · Tx: 1ra Línea: Cirugía de Resección Transesfenoidal del adenoma somatotropo. Terapia médica coadyuvante: Análogos de Somatostatina (Octreótido/Lanreótido) · Seg: Monitoreo anual con IGF-1 y GH post-PTGO. Colonoscopía periódica (riesgo elevado de pólipos premalignos y cáncer colorrectal) y ecocardiograma

GES

El examen de tamizaje inicial de primera elección con mayor sensibilidad diagnóstica para la pesquisa de Acromegalia es la determinación sérica del Factor de Crecimiento Insulínico tipo 1 (IGF-1 o Somatomedina C). A diferencia de la GH, cuyos niveles plasmáticos son pulsátiles y oscilan ampliamente a lo largo del día con picos aleatorios de estrés, la IGF-1 tiene una vida media prolongada y concentraciones estables en sangre que reflejan fielmente la actividad integrada de la GH durante las semanas previas. La medición de una GH basal matinal aislada es un error técnico grave y no se utiliza para tamizaje.

PREGUNTA 84

Respuesta: A

Acromegalia y Gigantismo: Diagnóstico Bioquímico y Manejo

1.04.1.015

Dx: Tamizaje: IGF-1 sérica elevada para edad y sexo. Confirmación: Test de Sobrecarga Oral de Glucosa (PTGO 75g con GH que no suprime a < 1.0 o 0.4 mcg/L) · Tx: 1ra Línea: Cirugía de Resección Transesfenoidal del adenoma somatotropo. Terapia médica coadyuvante: Análogos de Somatostatina (Octreótido/Lanreótido) · Seg: Monitoreo anual con IGF-1 y GH post-PTGO. Colonoscopía periódica (riesgo elevado de pólipos premalignos y cáncer colorrectal) y ecocardiograma

GES

La prueba diagnóstica estándar de oro confirmatoria de la Acromegalia es el Test de Sobrecarga Oral de Glucosa (PTGO con 75 g de glucosa). En individuos sanos, la hiperglicemia inducida actúa sobre el hipotálamo y la hipófisis suprimiendo potentemente la liberación de hormona de crecimiento hasta valores menores a 1.0 mcg/L (o < 0.4 mcg/L en ensayos ultrasensibles). En los pacientes con acromegalia, el adenoma somatotropo posee autonomía funcional absoluta, demostrándose una falla patológica en la supresión de la GH (persiste ≥ 1.0 mcg/L).

PREGUNTA 85 **Respuesta: B**

Hipopituitarismo, Síndrome de Sheehan y Panhipopituitarismo

1.03.1.014

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

Es un síndrome de Sheehan clásico, que cursa con hipopituitarismo.

PREGUNTA 86

Respuesta: B

Hipopituitarismo, Síndrome de Sheehan y Panhipopituitarismo

1.04.1.016

Dx: Hormonas diana disminuidas (Cortisol, T4L, Estradiol/Testosterona) con tropinas hipofisarias bajas o 'inapropiadamente normales' (ACTH, TSH, LH/FSH) · Tx: Reemplazo hormonal escalonado. REGLA DE ORO DE SEGURIDAD: Iniciar SIEMPRE Glucocorticoides (Hidrocortisona) ANTES que Levotiroxina · Seg: Monitoreo clínico, densitometría ósea y ajuste periódico de dosis según bienestar, peso y presión arterial. NUNCA guiar levotiroxina con TSH

GES

Una de las reglas más estrictas y evaluadas con mayor énfasis en el examen EUNACOM en relación al panhipopituitarismo es la secuencia cronológica mandatoria de reemplazo hormonal: SIEMPRE se deben administrar GLUCOCORTICOIDES (Hidrocortisona) ANTES de iniciar la hormona tiroidea (Levotiroxina). Si se administra levotiroxina a un paciente con déficit concomitante de ACTH/cortisol sin cobertura previa, la inducción del hipermetabolismo celular incrementa aceleradamente la degradación hepática y el aclaramiento del escaso cortisol plasmático residual, lo que desencadena de forma inmediata una Crisis Suprarrenal Aguda con shock circulatorio potencialmente letal.

PREGUNTA 87

Respuesta: B

Hipopituitarismo, Síndrome de Sheehan y Panhipopituitarismo

1.04.1.016

Dx: Hormonas diana disminuidas (Cortisol, T4L, Estradiol/Testosterona) con tropinas hipofisarias bajas o 'inapropiadamente normales' (ACTH, TSH, LH/FSH) · Tx: Reemplazo hormonal escalonado. REGLA DE ORO DE SEGURIDAD: Iniciar SIEMPRE Glucocorticoides (Hidrocortisona) ANTES que Levotiroxina · Seg: Monitoreo clínico, densitometría ósea y ajuste periódico de dosis según bienestar, peso y presión arterial. NUNCA guiar levotiroxina con TSH

GES

En los pacientes con Hipotiroidismo Central (secundario o terciario por hipopituitarismo), la secreción hipofisaria de TSH se encuentra dañada de forma irreversible e intrínseca, por lo que los niveles séricos de TSH permanecerán siempre bajos, indetectables o inapropiadamente normales e independientes del estado tiroideo real del organismo. Por esta razón, la TSH carece por completo de utilidad clínica para monitorizar o titular la dosis de levotiroxina. El único parámetro biológico válido para evaluar la adecuación del tratamiento sustitutivo tiroideo en el hipopituitarismo es la concentración sérica de T4 LIBRE, debiendo ajustarse la dosis de levotiroxina para mantener la T4 libre en la mitad superior del rango normal de referencia.

PREGUNTA 88 **Respuesta: D**

Diabetes Insípida, SIADH y Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN)

1.03.1.015

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

Diabetes insípida central

PREGUNTA 89

Respuesta: B

Diabetes Insípida, SIADH y Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN)

1.04.1.017

Dx: Poliuria hipotónica: Osm urinaria < 300 mOsm/kg + Test de deprivación hídrica (Miller) y Desmopresina. Hiponatremia euvolémica: SIADH (Osm orina > 100) · Tx: DI Central: Desmopresina (DDAVP) nasal u oral. DI Nefrogénica: Hidroclorotiazida + Amilorida. SIADH: Restricción de fluidos (500-1000 mL/d) · Seg: Monitoreo estricto de sodio plasmático para evitar Síndrome de Desmielinización Osmótica (corrección máxima < 8-10 mEq/L en 24h)

GES

El paciente presenta una Diabetes Insípida Central Aguda, complicación clásica y muy frecuente tras cirugías neuroquirúrgicas de la región selar o supraselar (como resección de craneofaringiomas o adenomas hipofisarios con manipulación del tallo hipofisario). La falta aguda de liberación de ADH provoca una incapacidad del túbulo colector para reabsorber agua libre, desencadenando poliuria hipotónica masiva (orinas muy diluidas con densidad < 1.005 y osmolaridad urinaria < 300 mOsm/kg) con hipernatremia resultante. La respuesta contundente a la administración de Desmopresina (aumento de la osmolaridad urinaria > 50-100% y colapso de la diuresis) confirma que el defecto radica en la falta central de hormona y no en una resistencia renal periférica.

PREGUNTA 90

Respuesta: B

Diabetes Insípida, SIADH y Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN)

1.04.1.017

Dx: Poliuria hipotónica: Osm urinaria < 300 mOsm/kg + Test de deprivación hídrica (Miller) y Desmopresina. Hiponatremia euvolémica: SIADH (Osm orina > 100) · Tx: DI Central: Desmopresina (DDAVP) nasal u oral. DI Nefrogénica: Hidroclorotiazida + Amilorida. SIADH: Restricción de fluidos (500-1000 mL/d) · Seg: Monitoreo estricto de sodio plasmático para evitar Síndrome de Desmielinización Osmótica (corrección máxima < 8-10 mEq/L en 24h)

GES

El cuadro clínico y la constelación familiar corresponden de manera inequívoca a un Síndrome de Neoplasia Endocrina Múltiple tipo 1 (NEM 1 o Síndrome de Wermer). Este síndrome autosómico dominante está causado por mutaciones germinales inactivadoras en el gen supresor de tumores MEN1, ubicado en el cromosoma 11q13, el cual codifica para la proteína menina. Se caracteriza clínicamente por la presencia combinada de la clásica tríada de las 3 'P': 1) Paratiroides (hiperparatiroidismo primario en > 95% de los portadores); 2) Páncreas / tracto gastroenteropancreático (gastrinomas, insulinomas); y 3) Pituitaria o hipófisis anterior (prolactinomas y somatotropinomas). Las mutaciones del gen RET causan NEM 2A y 2B.
